

Zdravje v občini Črnomelj

Od podatkov do ukrepov

Kje se zdravje izboljšuje, katere vrzeli ostajajo in kaj lahko skupaj naredijo občina, zdravstveni dom, šole in prebivalci. S preverjeno oceno dela Centra za krepitev zdravja in načrtom za naslednja leta.

Osnova: 19. september 2026; kader in šport: 21. september 2026

Izdaje NIJZ 2016–2026

Uradni viri · raziskave · lokalne objave

PREHRANJENOST OTROK

28,3 %

Slovenija 24,18 %. Podatek za 2024, izdaja NIJZ 2026. [1]

PRESEJANOST DORA

82,08 %

Slovenija 77,93 %. Obdobje januar 2024–oktober 2025. [1]

NESREČE IN ALKOHOL

12,94 %

Slovenija 8,22 %. Povprečje 2020–2024. [1]

DOKUMENTIRANO DELO CKZ

3,4 / 5

Analična ocena petih javno preverljivih meril. Učinkovitost ostaja neocenjena. Metoda ocenjevanja ↓

01 Ključne ugotovitve in prednostne naloge

Najnovejši občinski profil potrjuje višjo prekomerno prehranjenost otrok, nadpovprečen delež nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji in dobro vključevanje v Svit ter DORO. Pri večini drugih razlik je treba upoštevati statistično negotovost. [2]

UGOTOVITEV	KAJ POMENI ZA ODLOČANJE
Otroci: izboljšanje ob vztrajni vrzeli. Delež je med izdajama 2016 in 2026 padel z 31,1 na 28,3 %, v vseh enajstih izdajah pa ostaja nad slovenskim povprečjem. [3]	Ohraniti družinsko obravnavo, razširiti redno gibanje in izboljšati prehransko okolje. Trditev starega poročila, da izboljšanja sploh ni, je napačna.
Srčna kap je številčno pod povprečjem, možganska kap mu je blizu. Zadnji stopnji sta 1,66 proti 1,86 in 2,26 proti 2,21 na 1.000. [3]	Gre za bolnišnične obravnave in večletna povprečja. To ni dokaz uspeha posameznega programa; profil pri obeh zadnjih vrednostih ne označuje statistično značilne razlike. [2]
CKZ ima javno imenovano vodjo in raznoliko dejavnost. Uradna stran imenuje Tatjano Gregorič in strokovne sodelavce. [4] Letno poročilo navaja izvedbo načrtovanih ur. [5]	Prejšnji očitki o neznanem vodstvu se umakne. Naslednja naloga je pregledno poročanje o številu različnih uporabnikov, stroških in izidih.

UGOTOVITEV	KAJ POMENI ZA ODLOČANJE
Dodane prezrte potrebe. Precepljenost proti pnevmokokom je 44,4 proti 55,2 %, pomoč na domu 1,0 proti 1,8 %. [2]	Preventiva vključuje tudi cepljenje, podporo starejšim in dostopnost oskrbe. CKZ teh vrzeli ne more odpraviti sam.

02 Kako brati in primerjati podatke

Preverjena je aktualna publikacija NIJZ za Črnomelj, izdana aprila 2026, in vseh 54 lokalnih Excelovih časovnih nizov. Grafi prikazujejo **leto objave**. Posamezna izdaja združuje meritve iz različnih preteklih obdobj. [2][3]

SKUPINA PODATKOV	REFERENČNO OBDOBJE V IZDAJI 2026	OMEJITEV
Prehranjenost otrok in odraslih, Svit, zdravila, bolniška odsotnost	2024	To niso meritve zdravstvenega stanja v septembru 2026.
DORA / ZORA	DORA: 1. 1. 2024–31. 10. 2025. ZORA: 1. 7. 2021–30. 6. 2024.	Različni programi, starostne skupine in obdobja.
Umrljivost, srčna in možganska kap, alkoholne bolezni, nesreče	Povprečje 2020–2024	Sosednje izdaje se časovno prekrivajo; to niso neodvisna letna opazovanja.
Novi primeri raka	Povprečje 2018–2022	Daljši zamik; ni primerno za oceno učinka dogodkov v 2025 ali 2026.
HPV / pnevmokok / OMR / DTP-Hib-IPV-hepB	HPV: kohorta šestošolcev 2023/24; preostali navedeni kazalniki: otroci, rojeni 2022.	Ne gre za precepljenost celotnega prebivalstva ali vseh starejših.

Obdobja so prepisana iz pojasnil pod tabelo NIJZ, str. 4 publikacije. [2]

Pomemben prelom pri umrljivosti. Izdaje 2016–2018 uporabljajo običajno bivališče, poznejše stalno. NIJZ pri splošni umrljivosti izrecno opozori na neprimerljivost. Na grafih je prelom označen in črta prekinjena. Standardizirane stopnje že upoštevajo različno starostno strukturo, zato višje stopnje ne pojasnimo preprosto s »starejšim prebivalstvom«. [6]

Razlika med točkovnima ocenama sama po sebi ne dokazuje statistično značilne razlike. Rdeča oziroma zelena oznaka NIJZ označuje potrjeno neugodno oziroma ugodno razliko, rumena neznačilno razliko, modra pa razliko, pri kateri smer ni enoznačno dobra ali slaba. Tako je lahko več prejemnikov zdravil tudi posledica boljšega odkrivanja in zdravljenja. [2][6]

► Celoten pregled 54 kazalnikov in prenos podatkov

03 Zdravstveni dom Črnomelj: zdravljenje in preventiva

ZD Črnomelj je javni zavod z ustanoviteljico Občino Črnomelj; izvaja dejavnost tudi za Semič in deluje v Črnomlju, Semiču ter Vinici. Spodaj so podatki za zaključeno leto 2025, ne nepotrjena ocena poslovanja v 2026. [5]

PODATEK ZA 2025	VREDNOST	RAZLAGA
Prihodki / odhodki	9.753.579 € / 9.457.216 €	Prihodki so glede na 2024 višji za 17,94 %, odhodki za 18,67 %. Prejšnja navedba 15,8 % rasti prihodkov je popravljena.
Presežek	296.363 € pred davkom 294.256 € po davku	Poslovni izid celega zavoda ne pove, koliko stane CKZ.
Zadovoljstvo pacientov	4,57 / 5; 143 anket	Prostovoljni odziv uporabnikov, brez dokaza reprezentativnosti za vse paciente; ni ocena CKZ.
Kadrovska težava	Pomanjkanje zdravnikov, posebej v dodatni ambulantni	Zavod poroča o težavah pri izvajanju programov. Potrebujemo podatke o čakanju, neopredeljenih osebah in obremenitvah po lokacijah.
Načrt programa CKZ	Plan 2025 vključuje prehrano, gibanje, stres, kajenje, sladkorno bolezen in družinsko obravnavo.	Načrtovane delavnice so cilji, ne avtomatično dokaz dejanske izvedbe vsake skupine. [7]

Viri: letno poročilo 2025, natisnjene str. 24–26 in 31; finančni načrt 2025, str. 17. [5][7]

04 Zdravstveni kader: obseg in metoda popisa

Presek javnih virov: 21. september 2026. Najbolj oprijemljiv primanjkljaj je v družinski medicini: ZD v programu 2026 navaja **7,53 priznanega in 5,53 zagotovljenega tima**, torej vrzel **2,00 tima** za območje njegovega delovanja, ki vključuje tudi Semič. To ni izračun iz evropskega povprečja. [8]

Za psihološko pomoč so v ZD imenovane tri psihologinje, vendar ima ena objavljeno dolgotrajnejšo odsotnost. Dve imata objavljen urnik, kar še ne pomeni dveh polnih zaposlitev, namenjenih eni ambulantni. [9] Popolnega občinskega seznama vseh trenutno dejavnih zasebnikov, njihovih ur in prostih mest iz pregledanih virov ni mogoče sestaviti. Spodnje številke zato ločujejo potrjen podatek, dokumentirani minimum in neznano skupno število.

Pravila štetja oseb, timov in izvajalcev

ENOTA	POMEN IN OMEJITEV
Oseba	Posameznik se šteje enkrat, tudi če dela v CKZ in dispanzerju ali javno in zasebno.
Zaposleni	Zadnji zaključeni kadrovski stanji sta na 31. 12. 2025. Nista seznam prisotnih septembra 2026.
Tim / obseg dela	Financirani oziroma izvajani program. Ni isto kot število zaposlenih ali delež polnega delovnega časa posameznika.
Lokacija	Štejemo kraj obravnave, ne zgolj registriranega sedeža podjetja. Ambulanto v Semiču izločimo iz občine Črnomelj.
Aktivna ponudba	Objavljen urnik oziroma ponudba ob preverbi; telefonska potrditev izvajanja in prostih mest ni bila opravljena.
Šport	Ločimo dokumentirano vadbo, klub iz imenika in posamezen rekreativni dogodek. Vpis društva ni dokaz tekočih treningov.

05 Psihologi, psihiatri in psihoterapija

PROFIL	JAVNI ZAVODI / JAVNA MREŽA	ZASEBNO IN OMEJITVE ŠTETJA
Psihologinje	3 zaposlene v ZD konec 2025. Imenovane so Marina Strahinić, Lea Štravs in dr. Sabina Prah; slednja je po obvestilu odsotna do nadaljnjega. Marina in Lea imata objavljen urnik. [5][9]	Celotno število zasebnih psihologov ni potrjeno. Lea Štravs je navedena tudi v CKZ in se ne šteje še enkrat. [10]
Psihiater / nevropsihiater	V pregledanem seznamu ambulant ZD ni ločene psihiatrične ambulante. DSO objavlja obiske specialista nevropsihiatra vsaka dva tedna po štiri ure , namenjene stanovalcem doma; ne gre za polno občinsko ambulantno. Ime in aktualna pogodba nista objavljena v uporabljenem viru. [11][12]	Število zasebnih lokalnih psihiatričnih ambulant ni potrjeno. Nezmožnost potrditve ni dokaz, da jih je nič. ZD Metlika ima imenovano psihiatrinjo, vendar je to druga občina. [13]
Psihoterapija	ZD psihologov ne preimenujemo avtomatično v psihoterapevte. Starejši imenik iz 2023 navaja samoplačniško kognitivno-vedenjsko terapijo dr. Sabine Prah; to ni dokaz njene razpoložljivosti v 2026. [14][15]	Najmanj ena aktualno objavljena lokalna ponudba: Darinka Jerčinovič, Griblje, ki se predstavlja kot specializantka logoterapije , z obravnavami v živo ali na daljavo. To ni potrjen popis vseh dokončno usposobljenih psihoterapevtov. [16]

Pomembna razlika pri besedi »aktivni«: objavljeni septembrski seznam odsotnosti za Marino Strahinić in Leo Štravs navaja tudi 21. in 22. september; dveh rednih urnikov zato ne smemo razlagati kot dveh prisotnih psihologinj na dan te raziskave. Ni preverjeno, kdo ju takrat nadomešča. [15]

POT DO POMOČI	KONTAKT IN OBSEG
Otroci in mladostniki do 21. leta	Psihološka ambulanta ZD Črnomelj: 07 62 05 756, psiholog@zd-crnomelj.si . Objavljen je poseben septembrski urnik naročanja. [9]
Odrasli – preventivna podpora	CKZ: 07 30 61 723 ali 07 62 05 755, ckz@zd-crnomelj.si . Navedeni so programi spoprijemanja s stresom, tesnobo in depresijo ter psihologinja Lea Štravs. Ob naročanju preveriti ustrezen program in možnost individualne obravnave; preventivne delavnice niso enake specialističnemu zdravljenju. [10]
Specialistična psihiatrija v bližini	ZD Metlika , Daliborka Radivojević Vučković, dr. med., spec. psih.; 07 369 14 21, psihiatrija@zd-metlika.si . Stran navaja torek 15.00–22.00. Nedatirane navedbe čakalne dobe ne uporabljamo kot potrjenega aktualnega termina. [13]
Zasebna ponudba v Gribljah	Darinka Jerčinovič, specializantka logoterapije; naročanje prek profila Mojpsihoterapevt.si. Objavljena cena je 60 EUR na srečanje; pred naročilom preveriti termin, status usposabljanja in pogoje. [16]

Fizioterapija, prehrana, kineziologija in trenerji

PROFIL	KAJ LAHKO PREŠTEJEMO	KAJ OSTAJA NEZNANO
Fizioterapevti	6 zaposlenih v ZD konec 2025. Spletna stran fizioterapije imenuje Matejo Turk, Marto Judnič, Marto Rade, Mojco Šuštarč in Metko Štravs; CKZ dodatno Tjašo Klemenčič. DSO poroča še o eni zaposleni fizioterapevtki konec 2025, za stanovalce. [5][17][10][18]	To sta kadrovska podatka dveh zavodov, ne izmerjeni obseg sedmih splošno dostopnih ambulant. Skupno število aktivnih zasebnih fizioterapevtov v občini ni potrjeno.
Dietetiki in strokovnjaki za prehrano	ZD združuje 4 zaposlene v skupino »dietetiki, kineziologi« . CKZ javno imenuje Tino Resman, univ. dipl. inž. živil. teh., in Katjo Hudelja, mag. inž. prehrane . DSO ima v tabeli še eno pripravnico dietetiko . [5][10][18]	Skupine štirih zaposlenih ni mogoče zanesljivo razdeliti na poklice. Dveh objavljenih prehranskih profilov ne enačimo z dvema diplomiranima dietetikoma. Pripravnica ni samostojni specialistični izvajalec.
Nutricionisti / prehranski svetovalci	Ločene kadrovske kategorije »nutricionist« ni. Sportas imenuje dve prehranski svetovalki: Sanelo Zukanović in Leo Berkopec ; slednja navaja tudi izobrazbo diplomirane medicinske sestre. [19]	To je ponudba prehranskega svetovanja, ne dokaz dveh zaposlitev dietetika. Enotnega skupnega števila nutricionistov ni mogoče potrditi.
Kineziologi	V CKZ je poimensko potrjena Laura Muhič, dipl. kinez. ; celotna skupina dietetikov in kineziologov ima štiri zaposlene. [10][5]	Ena imenovana oseba je dokumentirani minimum, ne zanesljiv skupni seštevek ZD ali občine. Pripravniki in pogodbeni sodelavci se vodijo ločeno.
Osební in fitnes trenerji	Na lokalnih straneh so poimensko navedeni Simon Tomec (RC Simon), Sanela Zukanović in Danijela Mržljak (Sportas) : najmanj 3 . Z inštruktorico jahanja Ano Stariha so potrjeni najmanj 4 imenovani izvajalci vadbe ljudi iz tega vzorca. [20][19][21]	To ni število vseh trenerjev v občini ali zaposlenih za polni čas. Trenerji nogometa, rokomet in drugih klubov v ta minimalni vzorec niso sistematično vključeni.
Fitnes centri in studii	Potrjeni sta 2 ponudbi fitnes centra: RC Simon in Don Vito Gym Črnomelj ; dodatno 1 studio vodene vadbe Sportas . [22][23][24]	Tri vadbene lokacije niso tri enakovredno opremljene fitnes dvorane. Popis ni dokaz, da drugih izvajalcev ni.

IZVAJALEC VADBE	LOKALNA LOKACIJA	OBJAVLJENA PONUDBA
RC Simon	Čopova ulica 14, Črnomelj	Fitnes, osebno trenerstvo, skupinske vadbe, pilates in prehransko svetovanje. [22][25][20]
Don Vito Gym	Belokranjska cesta 36, Črnomelj	Fitnes in dostop 24/7. Napovedanega dodatnega prostora HYROX ne obravnavamo kot že odprtega. [23]
Sportas	Kanižarica 14B	Osebna in skupinska funkcionalna vadba ter prehransko svetovanje. Objavljeni kadrovski profili niso bili potrjeni po telefonu. [24][19]

Zakaj nekaterih zadetkov ne prištejemo: MD Rehab Lab predstavlja Davorina Matkoviča in Matica Muhiča ter naslov izvajanja v Novem mestu; Klinika Optimum za Roka Žagarja navaja Ljubljano; Rehab Studio za Dina Šunjergo in Najo Rebec navaja Ljubljano. Ti viri ne potrjujejo redne lokalne obravnave v Črnomlju, tudi če drug imenik pokaže lokalni poslovni sedež. To ni trditev, da občasno delo v Črnomlju ni mogoče. [26][27][28]

07 Zdravniki v lokalni osnovni zdravstveni mreži

ZZZS, stanje 1. 9. 2026: po izločitvi ambulate Gabrijele Plut v Semiču je v občini Črnomelj v seznamu splošnih ter otroških in šolskih ambulant **6 različnih družinskih zdravnikov in 2 pediatrijni**, skupaj **8 izbranih zdravnikov teh dejavnosti**. To ni celotno število vseh zdravnikov: izključuje zobozdravnike, druge specialistične ambulante, zdravnike urgence in nadomeščanja, ki v tem seznamu nimajo lastnega opredeljenega seznama. [29][15][30]

ZDRAVNIK	DEJAVNOST IN LOKACIJA	IZVAJALEC	OPREDELJENI 1. 9. 2026	SPREJEM NOVIH PO ZZZS
Ljiljana Špec	Družinska medicina, Črnomelj	ZD	1.198	NE
Jožica Fortun Tomažič	Družinska medicina, Črnomelj	ZD	1.503	NE
Mirela Mičić Despotović	Družinska medicina, Črnomelj	ZD	1.830	NE
Valerija Šimec	Družinska medicina, Vinica / del urnika Črnomelj	ZD	1.436	NE
Suzana Milenković	Družinska medicina, Zadružna cesta 33	Medicina MS, zasebnik v javni mreži	1.706	DA
Miro Vuković	Splošna ambulanta, Ulica 21. oktobra 19C	Zasebnik v javni mreži	772	NE
Eva Cimerman Jakša	Otroški in šolski dispanzer, Črnomelj	ZD	1.188	NE
Mateja Predalič	Otroški in šolski dispanzer, Črnomelj	ZD	1.527	NE

Vir celotne preglednice je ZZZS; lokacija Vinica in izločitev Semiča sta navzkrižno preverjeni pri ZD. »DA« **velja za datum seznama, ne zagotavlja sprejema danes**. Medicina MS objavlja kontakt **07 30 53 930**. [29][30][15][31]

Vseh osem vrstic skupaj predstavlja **11.160 opredelitev**. To ni število občanov s svojim zdravnikom: pacienti lahko prihajajo iz drugih občin, občani Črnomlja pa so lahko opredeljeni drugje. Zato iz razlike do števila prebivalcev ni dopustno izračunati števila oseb brez zdravnika. Pri Vukoviću vrstica zajema 0,45 tima splošne ambulate; njegovega dela za DSO ne prištevamo kot druge osebe. Njegova spletna stran navaja drugačno delitev programa, zato za datirani obseg te ambulate uporabimo novejšo preglednico ZZZS. [29][32]

Letno poročilo **ZD kot celote** za konec 2025 vsebuje **9 zaposlenih zdravnikov in 5 zdravnikov specializantov/sekundarijev**, torej 14 zaposlenih oseb v teh dveh kategorijah; zobozdravstvo je ločeno (**7 zobozdravnikov in 1 oseba v kategoriji zobozdravniki pripravniki/specializanti**). Teh števil ne seštevamo z osmimi iz zgornje preglednice, saj se osebe prekrivajo, datuma in območji pa se razlikujejo. Načrt za 2026 predvideva 10 zdravnikov in 5 specializantov/sekundarijev, vendar načrt ni dokaz realizirane zaposlitve. [5][8]

08 Razpoložljivost zdravnikov in kadrovske vrzeli

MERILO	UGOTOVITEV	PRAVILNA RAZLAGA
Pokritost priznanega programa ZD	7,53 priznanega – 5,53 zagotovljenega = 2,00 manjkajočega tima , približno 26,6 % priznanega programa. [8]	Konkretno dokumentiran primanjkljaj družinske medicine za območje ZD, tudi Semič. Smiselni prvi cilj je zapolnitev teh dveh timov z zdravniškim in podpornim kadrom. To ni nujno natanko dve novi osebi.
Stalni osebni zdravnik	ZD navaja 3.142 pacientov v ambulantah za neopredeljene na 1. 8. 2026 . [33]	Dokaz potrebe po nadomestni organizaciji, ne 3.142 občanov brez vsake oskrbe. Občinsko prebivališče in morebitno poznejše opredeljevanje nista razčlenjena.
Dejanska dostopnost za nove paciente	Med osmimi navedenimi zdravniki ima v preglednici 1. 9. 2026 samo Suzana Milenković oznako DA. [29]	Pokritost vseh občanov s stalno izbranim zdravnikom ni izkazana. Oznake je treba preverjati sproti.
Evropsko priporočilo	Poročilo Evropske komisije 2026 opisuje različne nacionalne pristope in potrebo po upoštevanju lokalnih razmer; ne določa enotnega občinskega števila zdravnikov. Model JRC SANDEM izrecno ni namenjen postavitvi univerzalnega razmerja zdravniki/prebivalci. [34][35]	Na podlagi teh virov ni pošteno podati »evropsko predpisanega« občinskega primanjkljaja.
Primerjava z EU	Profil OECD za 2025 navaja za leto 2023 3,5 zdravnika na 1.000 prebivalcev v Sloveniji in 4,3 v EU . [36]	Vključeni so zdravniki različnih ravni, tudi bolnišnični specialisti. Povprečje EU ni norma za družinsko medicino v vsaki občini. Iz njega ne odštevamo zaposlenih v ZD.

Za natančno oceno dodatnih potreb nad tema dvema timoma potrebujemo ure dela po specialnostih, starost in zdravstvene potrebe prebivalstva, število oseb brez izbranega zdravnika po občini prebivališča, čakalne dobe, upokojitve ter tokove pacientov med občinami. Za psihiatrijo, psihologijo, fizioterapijo in prehrano pregledani viri ne omogočajo verodostojnega izračuna, koliko novih polnih zaposlitev bi zadoščalo.

09 Športi in vadba v občini

Spodaj je **dokazljiv nabor, ne zagotovljeno izčrpen register vseh treningov 2026/27**. OŠ Loka je septembra 2025 poimensko dokumentirala deset izvajalcev popoldanske vadbe za otroke. To je dokaz lokalne ponudbe v 2025; aktualne starostne skupine, urnike, cene in prosta mesta je treba preveriti pri izvajalcu. [37]

ŠPORT / VADBA	IZVAJALEC	KAJ POTRJUJE VIR
Nogomet	Nogometna šola Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba za otroke, šolski pregled 2025. [37]
Rokomet	RK Črnomelj	Lokalna vadba 2025 in lastna klubska stran. [37][38]
Odbojka	Odbojkarski klub Črnomelj	Lokalna popoldanska vadba, šolski pregled 2025. [37]
Košarka	KK Kolpa Črnomelj; ŽKK Črnomelj	KK Kolpa je septembra 2025 objavil vpis in treninge v OŠ Mirana Jarca. ŽKK je v občinskem imeniku; njegov tekoči urnik ni preverjen. [39][40]

ŠPORT / VADBA	IZVAJALEC	KAJ POTRJUJE VIR
Atletika	Atletski klub Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba 2025. [37]
Tenis	TK Loka	Lastna stran ponuja rekreacijo, rezervacijo igrišč in belokranjsko ligo; termina šole tenisa za novo sezono ne potrjuje. [41]
Ju-jitsu	ŠD Ninja Črnomelj	Vadba za otroke 2025; lastna stran opredeli borilno veščino. [37][42]
Športno plezanje	Športno-plezalni odsek PD Črnomelj	Lokalna popoldanska vadba 2025. [37]
Lokostrelstvo	Lokostrelski klub Paradoks	Lokalna popoldanska vadba 2025. [37]
Kegljanje	Kegljaški klub Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba 2025. [37]
Twirling	Twirling klub Bela krajina	Lokalna popoldanska vadba 2025. [37]
Ples	Plesni studio Novo mesto – lokalne vadbe	Šola ga izrecno navaja med izvajalci vadbe v Črnomlju; ime Novo mesto ne pomeni, da vadba poteka samo tam. [37]
Jahanje	Horse Resort Stariha, Vražji kamen	Šola jahanja za otroke in odrasle, začetni in nadaljevalni tečaji. [21]
Praktično streljanje	Klub praktičnega streljanja Črnomelj	Lastna stran opisuje klub in strelišče v TRIS Kanižarica. Pogoje vključitve preveriti pri klubu. [43]
Fitnes, osebna in funkcionalna vadba, pilates	RC Simon, Don Vito Gym, Sportas	Objavljene lokalne ponudbe; posamezno vrsto in termin preveriti pri konkretnem izvajalcu. [22][23][24][20]
Nordijska hoja in vadba za zdravje	CKZ	Programi gibanja, testiranja in nordijske hoje; to niso vsi tekmovalni športni programi. [10]

DODATNA DEJAVNOST	STOPNJA POTRDITVE
Namizni tenis, tajski boks, šah, kolesarstvo, planinstvo, windsurfing in kasaštvo	Občinski imenik vsebuje ustrezna društva oziroma klube, vendar tekoči lokalni treningi niso preverjeni . Ne vključujemo jih v potrjeno ponudbo rednih treningov 2026/27. [40]
Kolesarski izleti, pohodi in tek v naravi	Občina napoveduje dogodke septembra–novembra 2026. Posamezna napoved dokazuje priložnost za udeležbo, ne celoletne šole oziroma treninga. [44]
Plavanje, veslanje / kajak / kanu / SUP, badminton, joga in drugi programi	Ta pregled nima dovolj aktualnih podatkov o redni strokovno vodeni lokalni vadbi . Možnost rekreacije ali obstoj igrišča/reke ne zadoščata za trditev, da poteka šola ali trening. Status: Unverified.

Priložnost za neposredno preverbo ponudbe je občinska napoved »**Športaj v mestu 2026**«, **23. 9. ob 16.00 v Športnem parku Loka**. Ob preseku raziskave je to prihodnji dogodek, ne že izvedena predstavitev. [44]

10 Ukrepi za boljšo dostopnost zdravstvenih storitev in vadbe

Naslednji ukrepi so **analitični predlogi**, ne sprejeti projekti ali potrjene finančne obveznosti. Ocene ur so okvir za organizacijo dela, ne ponudbene cene.

OBD OBJE	UKREP IN ODGOVORNI	OKVIR VIROV IN MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN KAZALNIK
0–12 mesecev	ZD s svetom zavoda pripravi izvedbeni načrt zapolnitve 2,00 tima; z občino razdeli potrebe po lokacijah.	40–80 ur za analizo in dogovore; nato stroškovnik kadra. Izvajanje iz pogodbeno urejenega programa ZZZS; občinski podporni ukrepi le po preverbi pristojnosti.	Stalnejša oskrba; tveganje neuspešnih zaposlitev. Meriti dejanske ure, zapolnjeni program, nove opredelitve in kontinuiteto, ne le števila razpisov.
0–12 mesecev	ZD in regionalne službe objavijo enotno pot do pomoči otrokom, odraslim in starejšim z nadomeščanji in datiranimi kontakti.	20–40 ur začetnega usklajevanja in 2–4 ure mesečnega vzdrževanja iz obstoječih organizacijskih sredstev.	Manj napačnih napotitev; tveganje zastarelih kontaktov. Meriti čas do prve ustrezne obravnave in neuspešne predaje.
0–12 mesecev	Občina / CKZ s klubi in zasebniki vzpostavi prostovoljno potrjen imenik: kraj, poklic, ure, starost, cena, prosta mesta, datum preverbe.	40–80 ur začetnega popisa ter 4–8 ur mesečno; občinski program športa/preventive in lastna sredstva sodelujočih, po preverbi upravičenosti.	Preglednejša ponudba; tveganje neodzivnosti in dvojnega štetja. Delež vnosov potrjenih v zadnjih 90 dneh ter število uspešnih vključitev.
1–3 leta	ZD z regionalnimi izvajalci preveri razširitev kliničnopsiholoških in psihiatričnih obravnav za odrasle, po potrebi gostujoče termine.	Najprej analiza potreb in čakalnih vrst; obseg in cena dodatnega programa še nista ocenljiva. Dogovor z ZZZS in izvajalci, morebitni namenski razpisi.	Boljši dostop; tveganje prerazporejanja istega redkega kadra. Meriti dodatne dejanske ure in čas čakanja.
1–3 leta	CKZ in športni izvajalci preizkusijo prehod v cenovno dostopno prilagojeno vadbo ter pomoč pri prevozu.	Pilot dveh skupin; strošek vaditeljev, prostora, prevoza in koordinacije določiti s ponudbami. Možni občinski športni/socialni programi in lastni viri; brez avtomatične pravice do financiranja.	Vztrajanje pri gibanju; tveganje osipa in neustrezne vadbe. Spremljati začetek, redno udeležbo, osip in funkcionalne rezultate.
3–10 let	Občina, ZD, DSO in regija letno usklajujejo potrebe, upokojitve, izobraževanje in dostopne prostore.	Letna kadrovska projekcija; naložbe šele po analizi potreb. Sredstva zavodov, ustanoviteljice in ustreznih državnih razpisov.	Vzdržnejša oskrba; tveganje naložb brez kadra. Meriti nezapolnjeni program, zadržanje kadra ter geografsko in finančno dostopnost.

11 Pohodne in kolesarske trase: zemljevid in prostorska bližina

Pregled 21. 9. 2026: obdelanih je **43 datotek GPX: 26 pohodnih in 17 kolesarskih**. Znotraj meje Črnomlja ima merljiv odsek **22 tras (14 pohodnih in 8 kolesarskih)**; **21 tras je v celoti zunaj te meje**. To je regionalna zbirka, ne 43 poti v celoti znotraj občine. Pri Poti Gozdna železnica gre le za približno **40 m obmejnega odseka**, zato je treba pripadnost te poti preveriti tudi na uradni meji. [45][46]

Najmočnejša ugotovitev je razlika med vrstama aktivnosti: do pohodniške trase je znotraj **1 km zračne razdalje 62 od 111 točk krajev (55,9 %)**, do kolesarske pa **89 (80,2 %)**. Točke krajev niso gospodinjstva ali urejeni vstopi na pot; deleža **nista deleža prebivalcev**. [45][46]

— Pohodne — Kolesarske — Meja občine — Kraj več kot 1 km od katerekoli trase



Podlaga: © sodelavci OpenStreetMap, ODbL, zajem 20. 9. 2026; [46]. GPX: datoteke naročnika; [45]. Zemljevid deluje brez omrežja. Črtkane, blede trase so zunaj občine; v kazalnikih niso upoštevane.

► [Seznam vseh 43 tras z dolžinami in prenos](#)

Predložene trase in dolžine odsekov v občini

VRSTA	DATOTEKE	Z ODSEKOM V OBČINI	CELOTNE TRASE (KM)	ODSEKI V OBČINI (KM)
Pohodništvo	26	14	265,7	143,9
Kolesarstvo	17	8	751,7	292,5
Skupaj	43	22	1.017,3	436,4

To so vsote dolžin posameznih tras. Ponovni prehodi po odseku in skupni odseki več tras so šteti večkrat; **436,4 km ni dolžina edinstvenega omrežja ali zgrajenih ločenih poti**. Kolesarski GPX lahko poteka po navadni cesti, pohodni po kolovozu. Oblike infrastrukture iz same sledi ne ugotovimo. Dolžine so dvodimenzionalne in ne vključujejo višinske komponente. [45][46]

Bližina tras krajem in občinskemu ozemlju

BLIŽINA TRASE	POHODNE: KRAJI	KOLESARSKE: KRAJI	KATERAKOLI: KRAJI	DELEŽ OZEMLJA: POHODNE / KOLESARSKE / KATERAKOLI
0,5 km	52/111 (46,8 %)	67/111 (60,4 %)	80/111 (72,1 %)	20,9 % / 38,4 % / 46,6 %
1 km	62/111 (55,9 %)	89/111 (80,2 %)	96/111 (86,5 %)	35,4 % / 62,9 % / 70,9 %
2 km	84/111 (75,7 %)	109/111 (98,2 %)	110/111 (99,1 %)	61,5 % / 91,4 % / 94,4 %

Razdalje 0,5 / 1 / 2 km so **analitični pragovi**, ne zdravstveni, evropski ali prometni standard. Delež ozemlja meri geometrijsko bližino, vključno z gozdovi in neposeljenimi območji. Pasovi so unija, prekrivanje se pri površini ne podvaja. Skupna bližina obeh vrst ne pomeni, da je kolesarska trasa primerna za pešce. [45][46]

Prednostna območja za preverbo dostopa

KRAJ (TOČKA OSM)	DO POHODNE TRASE	DO KOLESARSKE TRASE
Vranoviči	5,6 km	3,5 km
Ručetna vas	5,4 km	0,6 km
Zastava	5,0 km	1,4 km
Mihelja vas	4,9 km	0,7 km
Pavičiči	4,8 km	0,8 km
Petrova vas	4,4 km	1,0 km
Gorenja Paka	4,4 km	1,7 km
Rožanec	4,0 km	1,2 km

Prednostna preverba za hojo: Vranoviči, Ručetna vas, Zastava, Mihelja vas in Pavičiči. Razvrstitev je po oddaljenosti od predloženih pohodnih GPX, ne po številu prebivalcev, starosti ali prometni nevarnosti. Obstoječe lokalne poti, ki jih v zbirki ni, lahko sliko bistveno spremenijo. [45][46]

Pri kolesarjenju sta najdlje Vranoviči (3,49 km) in Miliči (2,44 km). Vranoviči so edina od 111 zajetih točk več kot 2 km od katerekoli obravnavane trase znotraj občine. Za ukrepanje najprej preveriti, ali manjka GPX, označena povezava ali dejansko varna infrastruktura. [45][46]

Možnosti za vsakodnevno gibanje in omejitve podatkov

V celoti oziroma vsaj 95-odstotno znotraj občine sta v zbirki **le dve celotni pohodniški trasi dolgi največ 5 km**: Ribja pot – srčna pot Svibnik (4,64 km) in Učna pot Grički kal (4,61 km). Prag 5 km je raziskovalni izbor krajših tras, **ne priporočena razdalja za vsakega uporabnika**. Podatki ne potrjujejo zahtevnosti, prehodnosti z vozičkom, klopi, sence, dostopa brez avtomobila ali dovoljenosti prehoda. [45][46]

Kolesarska krožna pot Črnomelj meri 10,39 km, od tega 10,39 km v občini. Druge lokalno prisotne kolesarske trase so daljše regionalne ture ali njihovi odseki. Za vsakodnevno preventivno vadbo je smiselno **preveriti in opisati krajše uporabne odseke**, ne vsake celotne ture predstavljati kot primerne za začetnike. Pot Dobličica je v mapi pohodnih poti, njeno interno ime GPX pa je »Morning Ride«; vrsta dejavnosti zato zahteva potrditev. [45][46]

Metoda izračuna in omejitve

KORAK	POSTOPEK IN OMEJITEV
Vhod	Vseh 43 predloženih GPX, 67.518 trasnih točk; razvrstitev po mapah. Izračun ni dopolnjeval manjkajočih poti.
Razmejitev	OpenStreetMap, relacija 1685747, zajem 20. 9. 2026; izračunana površina približno 339,4 km². OSM ni uradna geodetska meja.
Dolžine	Vsak segment ločeno, brez povezovanja konca enega z začetkom naslednjega. Za lokalno dolžino je posebej obrezan vsak zaporedni par točk: ponovni prehodi so ohranjeni. WGS84 geodetska dolžina; preseki s poligonom občine v UTM 33N.
Kraji	111 točk tipa town/village iz obstoječega OSM zajema. Brez zaselkov tipa hamlet, brez uteži prebivalstva in brez trditve, da gre za vsa uradna naselja.
Razdalja	Najkrajša zračna razdalja do črte znotraj občine v metrih, ne samo do najbližje shranjene točke. Zunajobčinski odseki niso uporabljeni za ta kazalnik.
Pasovi	Polmer 500 / 1.000 / 2.000 m, unija in presek z občino. Za površino so trase poenostavljene največ 5 m; loki imajo 16 odsekov na kvadrant. Zemljevid dodatno poenostavi pasove za 20 m, kar ne spremeni že izračunanih tabel.
Kakovost	0 neveljavnih koordinat, 0 povsem enakih geometrij datotek. Največji razmik zaporednih točk je 537 m: GPX med točkami predpostavlja ravno povezavo. Brez terenske potrditve.
Česa ne merimo	Prebivalcev v dosegu, časa hoje/vožnje, prometa, podlage, naklona, zapor, lastništva, oznak, stroškov, vzdrževanja in zdravstvenega učinka. Datumi v GPS posnetku niso datum terenske preverbe.

Predlagani naslednji koraki

Ukrepi so raziskovalni predlogi. Okvir ur je orientacijska organizacijska ocena, ne ponudba ali potrjen občinski strošek.

ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI / MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN KAZALNIK
0–3 mesec e	RIC, občina in lokalna društva preverijo 43 vnosov, prvotni vir, upravljavca, označenost ter manjkajoče trase. Najprej razjasnijo 40 m mejnega stika Poti Gozdna železnica in vrsto poti Dobličica.	20–40 ur pisarniškega dela; obstoječa sredstva upravljavcev.	Uporaben register; tveganje neodzivnosti. Delež poti s potrjenim upravljavcem in datumom preverbe.

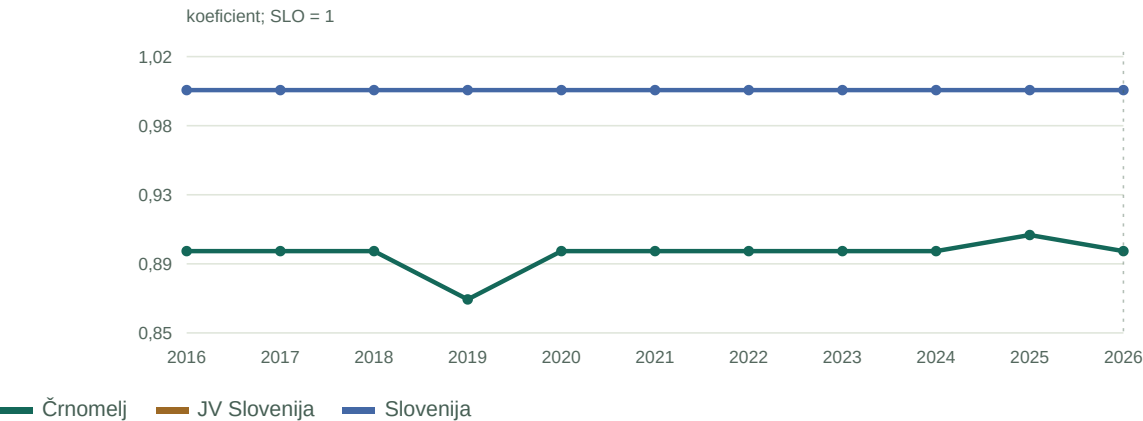
ROK	UKREP IN ODGOVORNI	VIRI / MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN KAZALNIK
0–12 mesec ev	Občina, KS in CKZ preverijo dostopne kratke odseke pri Vranovičih, Ručetni vasi in drugih oddaljenih krajih ter pri Svibniku/Griču opravijo ogled obstoječih krajših tras.	5–8 terenskih ogledov po 2 osebi, približno 40–80 človek-ur; občinski program športa/turizma in sredstva partnerjev.	Loči vrzel podatkov od vrzeli dostopa; tveganje neurejenih pravic ali cestnih prehodov. Število opisov z varnim dostopom, podlago, ovirami in dolžino.
1–3 leta	Na podlagi ogledov urediti prednostne manjkajoče povezave, označevanje in dogovorjeno vzdrževanje; odgovorni občina, upravljavci cest in lastniki.	Ločen popis del in projektantska ocena; možni občinski proračun, LAS ali namenski razpisi, upravičenost še ni preverjena.	Več uporabnih povezav; tveganje gradnje brez uporabnikov ali vzdrževanja. Število potrjenih dostopnih povezav in števci uporabe.
1–3 leta	CKZ in društva preizkusijo redno vodeno hojo na preverjenih odsekih; spremljajo vključitev, vztrajanje in ovire dostopa.	Najprej dve skupini, okvirno 2–4 ure vodenja/koordinacije tedensko skupaj; sredstva programov izvajalcev.	Povezava poti z dejansko dejavnostjo; tveganje osipa. Udeležba po treh in šestih mesecih, ne samo število dogodkov.
3–10 let	Vzpostaviti letno obnavljan register poti in dostopa iz naselij, povezan z uradnimi prostorskimi podatki, prebivalstvom in proračunom.	Letni načrt vzdrževanja in podatkov; obseg naložb šele po prioritetah.	Trajnejša dostopnost; tveganje zastarelih podatkov. Delež prebivalcev z dejansko varnim dostopom po mreži in pravočasno izvedeno vzdrževanje.

12 Okolje in življenjske razmere

Koeficient razvitosti občine je sestavljen kazalnik za financiranje občin, katerega vir je Ministrstvo za finance. NIJZ ga objavlja, ne izračunava kot samostojno zdravstveno diagnozo. V prikazanih izdajah niha med 0,87 in 0,91; prvi in zadnji podatek sta 0,90. [6][3]

Razvitost občine

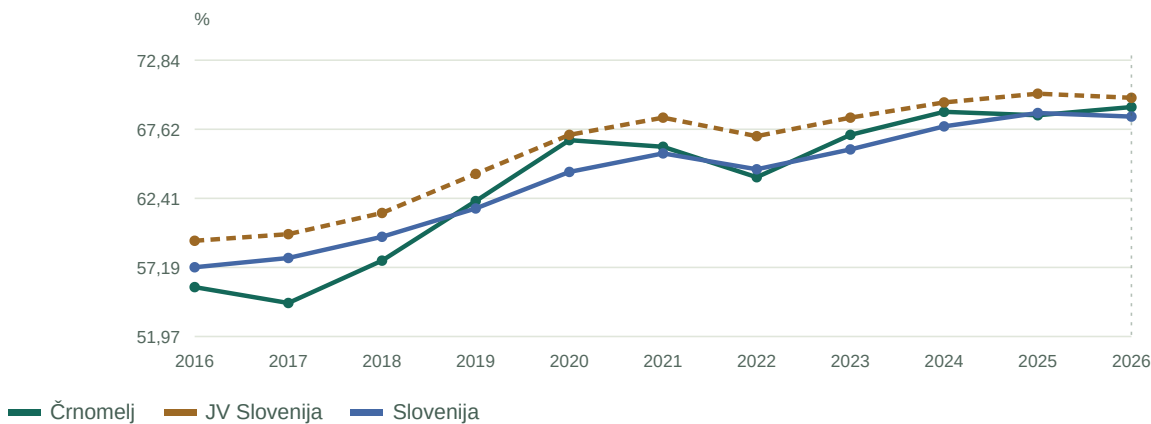
K1.1 · leto objave podatkov



0,87–0,91; ponovitev iste vrednosti ni nova letna meritev. [3]

Delovna aktivnost

K1.5 · leto objave podatkov



Zadnja izdaja 69,3 %; nad slovensko vrednostjo že v izdaji 2019. [3]

Delovna aktivnost je od prve do zadnje izdaje zrasla za 13,6 odstotne točke. Slovensko vrednost je presegla že v izdaji 2019, zato leto 2026 ni prvi tak primer. Kazalnika opisujeta okoliščine, ne dokazujeta lokalnih vzrokov bolezni. [3] Poročilo WHO o zdravstvenih neenakostih poudarja pomen življenjskih in delovnih razmer ter dostopa do virov; za Črnomelj bi morali te povezave preveriti z lokalnimi podatki. [47]

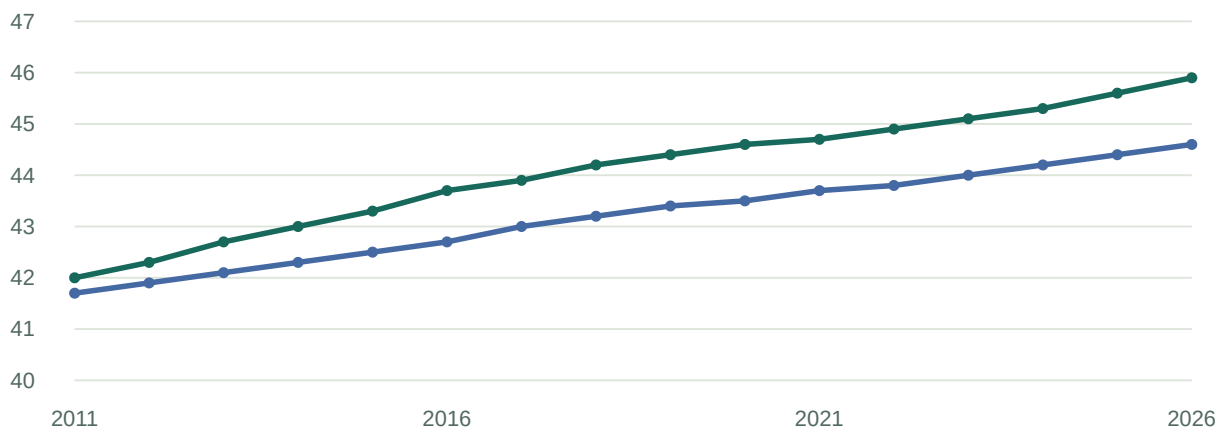
13 Starost prebivalcev in staranje občine

Na **1. januar 2026** ima občina **14 170 prebivalcev**. Povprečna starost je **45,9 leta**, kar je 1,3 leta nad slovenskim povprečjem (44,6). Delež starih 65 let ali več dosega **25,5 %**, v Sloveniji 22,5 %. [48][49]

Od začetka 2011 do začetka 2026 se je število prebivalcev zmanjšalo za 547 (3,7 %), število starih 65+ pa povečalo z 2.420 na 3.616 (+49,4 %). Število starih 15–64 let je upadlo z 10.266 na 8.502 (–17,2 %). Otrok 0–14 let je bilo 2.031, zdaj jih je 2.052; po letu 2021 se je njihovo število zmanjšalo. To opisuje spremembo sestave, ne dokazuje posameznega vzroka selitev ali staranja. [48]

Povprečna starost, 2011–2026

Zelena: Črnomelj · modra: Slovenija · stanje na 1. januar · v letih



Vir: SURS; vse vrednosti so tudi v spodnji tabeli. [49]

Prebivalstvo in starostne skupine po letih

LETO (1. 1.)	SKUPAJ	0–14 LET	15–64 LET	65+ LET	80+ LET¹	STAROST ČRNO MELJ	STAROST SLOVENIJA	INDEKS STARANJA
2011	14 717	2 031	10 266	2 420	676	42,0	41,7	119,2
2012	14 714	2 042	10 213	2 459	699	42,3	41,9	120,4
2013	14 629	2 058	10 054	2 517	747	42,7	42,1	122,3
2014	14 586	2 103	9 929	2 554	776	43,0	42,3	121,4
2015	14 591	2 104	9 837	2 650	811	43,3	42,5	126,0
2016	14 407	2 101	9 575	2 731	836	43,7	42,7	130,0
2017	14 365	2 071	9 473	2 821	867	43,9	43,0	136,2
2018	14 313	2 076	9 354	2 883	868	44,2	43,2	138,9
2019	14 299	2 078	9 254	2 967	859	44,4	43,4	142,8
2020	14 241	2 104	9 090	3 047	867	44,6	43,5	144,8
2021	14 308	2 159	8 995	3 154	828	44,7	43,7	146,1
2022	14 279	2 168	8 840	3 271	842	44,9	43,8	150,9
2023	14 236	2 122	8 759	3 355	849	45,1	44,0	158,1
2024	14 232	2 125	8 677	3 430	839	45,3	44,2	161,4
2025	14 213	2 079	8 621	3 513	835	45,6	44,4	169,0
2026	14 170	2 052	8 502	3 616	823	45,9	44,6	176,2

Oba spola skupaj; prebivalci celotne občine, ne samo mesta Črnomelj ali celotnega območja ZD. H1 pomeni stanje na 1. januar, ne letnega povprečja. Najnovejše stanje je 1. 1. 2026, objavljeno 18. 5. 2026. Povprečno starost uporabljamo neposredno iz SURS; ne izračunavamo je iz skupine 85+. Pri občinah SURS od 2011 uporablja enoletne starostne skupine, zato je glavni trend prikazan od 2011. Celotni prenos števil je za 2008–2026. ¹ Skupina 80+ je že vključena v 65+; teh stolpcev se ne sešteva. **[50]**

Prenesi letno tabelo CSV · Vse starosti, 2008–2026, Črnomelj in Slovenija

Koliko ljudi je v posamezni starostni skupini?

Stanje na 1. januar 2026. Zadnja skupina je odprta (85 let in več). **[48]**

STAROST	PREBIVALCI	DELEŽ (%)
0–4 let	617	4,4
5–9 let	704	5,0
10–14 let	731	5,2
15–19 let	713	5,0
20–24 let	539	3,8
25–29 let	601	4,2
30–34 let	712	5,0
35–39 let	907	6,4
40–44 let	987	7,0
45–49 let	1 096	7,7
50–54 let	950	6,7
55–59 let	914	6,5
60–64 let	1 083	7,6
65–69 let	1 090	7,7
70–74 let	998	7,0
75–79 let	705	5,0
80–84 let	358	2,5
85 let in več	465	3,3

► Odpri celotno tabelo: posamezna leta starosti 0–84 in 85+

Prenesi tabelo po posameznih letih starosti

Kaj to pomeni za zdravstveno poročilo?

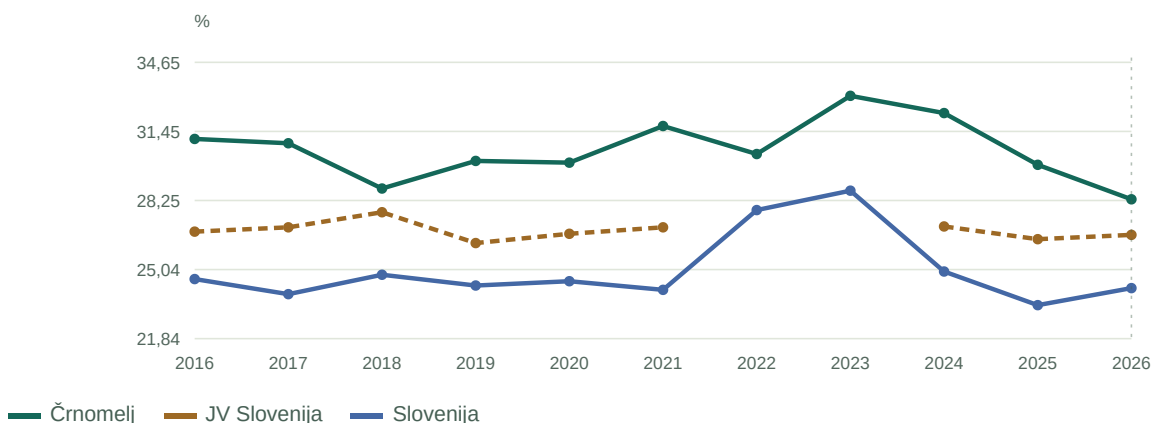
Več starejših pomeni večjo potrebo po dostopni obravnavi kroničnih bolezni, preprečevanju padcev, prevozi in pomoči na domu; to je načrtovalska interpretacija, ne izmerjena lokalna potreba po določenem številu mest. Delež

80+ je leta 2026 5,8 % v občini in 5,8 % v Sloveniji (pri objavi na eno decimalko). Podobnost pri najstarejših torej ne pomeni enake povprečne starosti ali deleža 65+. [49] Starostno standardiziranih zdravstvenih stopenj tudi po tej dopolnitvi ne pojasnjujemo zgolj s starejšim prebivalstvom. [6]

14 Otroci, prehrana in alkohol: kazalniki tveganja

Prekomerna prehranjenost otrok

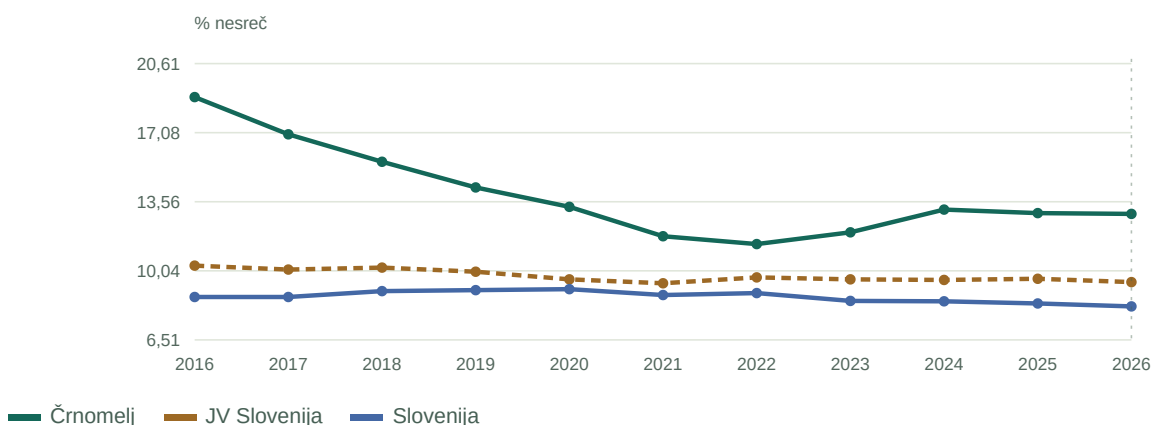
K2.2 · leto objave podatkov



Izdaja 2026: meritve 2024. Preddebelost in debelost skupaj. [3]

Nesreče z alkoholiziranimi povzročitelji

K2.6 · leto objave podatkov



Izdaja 2026: povprečje 2020–2024; ne število nesreč v 2026. [3]

Prednostna naloga: okolje za zdravo odraščanje. Vrzel pri prekomerni prehranjenosti otrok je v zadnji izdaji 4,12 odstotne točke. V celotnem nizu se giblje med 2,6 in 7,6 točke. Otroci niso edini kazalnik z vztrajnim odstopanjem: nad povprečjem ostajajo tudi nesreče z alkoholom in prejemniki zdravil za tlak. [3]

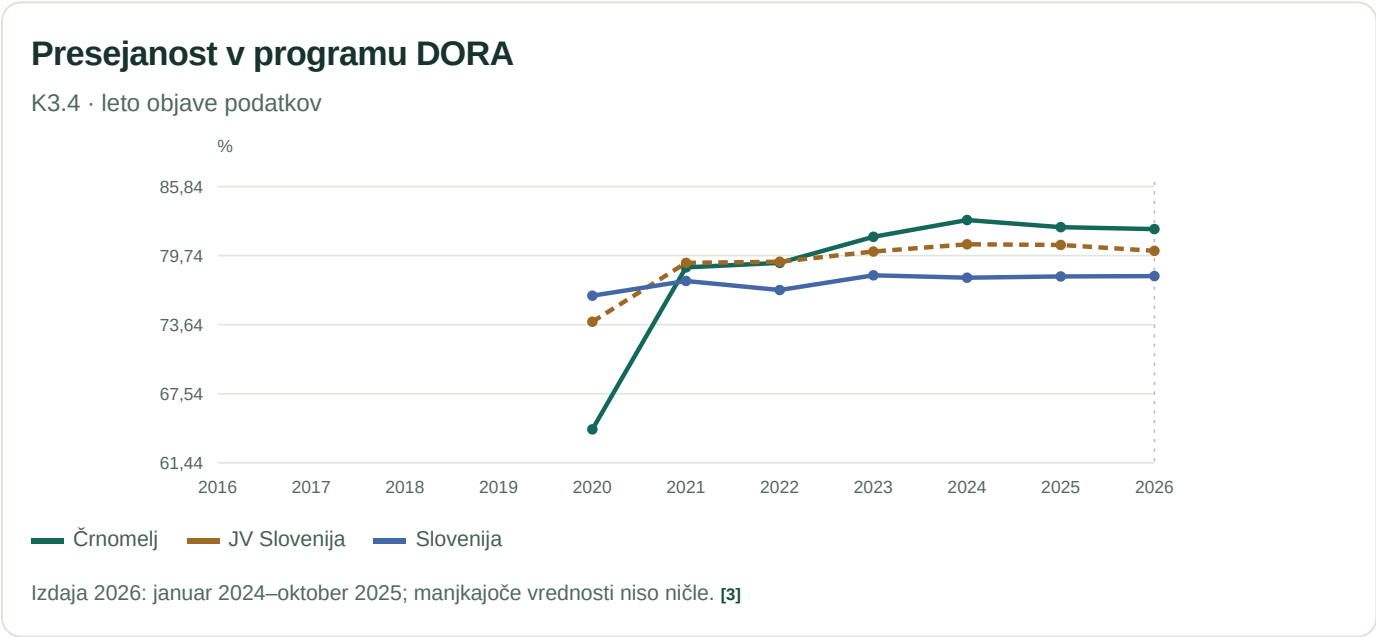
DODATNI KAZALNIK	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	KAJ LAHKO SKLEPAMO
Kadilci, objava 2021	23,7 %	23,2 %	Starejši anketni kazalnik; ni neposredno primerljiv z dnevnim kajenjem v OECD.
Visokotvegano opijanje, objava 2021	46,2 %	42,8 %	Opozorilni signal starejših anketnih podatkov, ne tekoča razširjenost v 2026.
Prekomerna prehranjenost odraslih, objava 2026	61,64 %	59,78 %	Vključuje preddebelost in debelost; meritev 2024. Razlika v profilu NIJZ ni označena kot statistično značilna.
Uporaba marihuane, objava 2026	14,04 %	21,96 %	Podatek 2023; definicija uporabe in anketna negotovost omejujeta interpretacijo.

Lokalni nizi in profil NIJZ. [3][2]

Delež nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji je med prvo in zadnjo izdajo nižji za približno 31,5 %, ne za polovico. Zadnja občinska vrednost je približno 57,4 % nad slovensko. Ta delež ne meri količine popitega alkohola in ne zajame vseh posledic pitja. [3][6]

15

Presejanje in dostopnost preventive



DORA je od izdaje 2021 nad slovenskim povprečjem; tudi Svit v zadnji izdaji dosega višjo odzivnost. To je uspeh širšega sistema vabljenja, izvajalcev in prebivalcev. Iz teh podatkov ni mogoče izločiti samostojnega prispevka CKZ. [3]

KAZALNIK, IZDAJA 2026	ČRNOMELJ / SLOVENIJA	DOKAZ IN PREDNOSTNI ODZIV
Svit	68,14 / 64,94 %	NIJZ označuje ugodno razliko. Ohraniti podporo pri odzivu in preveriti skupine z nižjo udeležbo.
ZORA	71,96 / 72,48 %	Majhna, statistično neznajčilna razlika. Ugotoviti razloge za neodziv posameznih skupin.

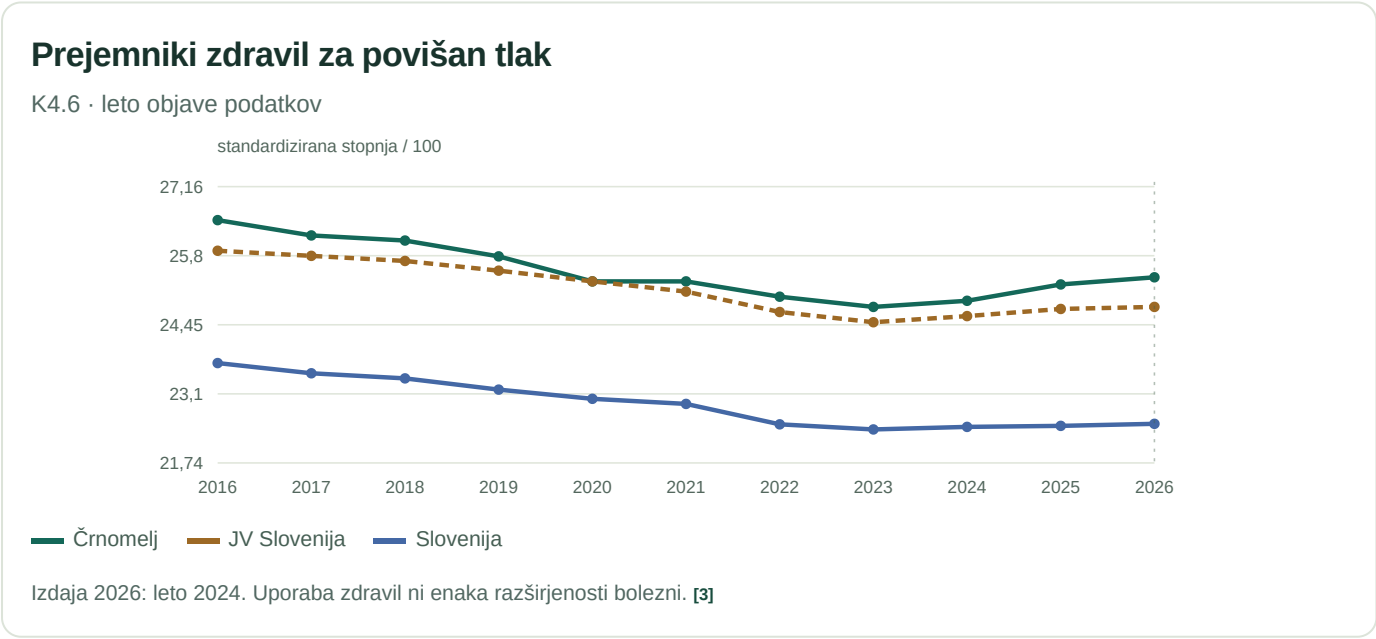
KAZALNIK, IZDAJA 2026	ČRNOMELJ / SLOVENIJA	DOKAZ IN PREDNOSTNI ODZIV
HPV	40,7 / 46,3 %	Šestošolska kohorta; statistično neznačilna razlika. Preveriti informiranje staršev in dostop do cepljenja.
Pnevmokok	44,4 / 55,2 %	Otroci, rojeni 2022; NIJZ označuje neugodno razliko. Pediatrija naj preveri zamujene odmerke in razloge.
OMR / DTP-Hib-IPV-hepB	88,10 / 86,94 % 83,33 / 85,61 %	Pri obeh razlika ni statistično značilna; rezultat nad povprečjem še ne pomeni zadostne zaščite.
Umivanje zob	63,0 / 68,7 %	Anketni kazalnik 2024; razlika ni statistično značilna. Nadaljevati praktično podporo ustni higieni.
Zlomi kolka, 65+	6,5 / 6,0 na 1.000	Standardizirane bolnišnične obravnave 2020–2024; razlika ni statistično značilna. Preveriti padce in dostop do vadbe ravnotežja.
Pomoč na domu, 65+	1,0 / 1,8 %	NIJZ označuje neugodno razliko. Občina in izvajalec naj preverita potrebe, čakalni seznam in ovire.

Natančne decimalke so iz Excelovih nizov; za dodatne kazalnike so prikazane zaokrožene vrednosti iz uradnega profila, str. 4. Statistične oznake so preverjene tudi vizualno. [3][2]

Profil 2026 posebej izpostavlja demenci prijazno skupnost. Smiselna lokalna dopolnitev so usposobljeni javni uslužbenci in podpora svojcem; iz profila ni mogoče izračunati števila oseb z demenco v Črnomlju. [2]

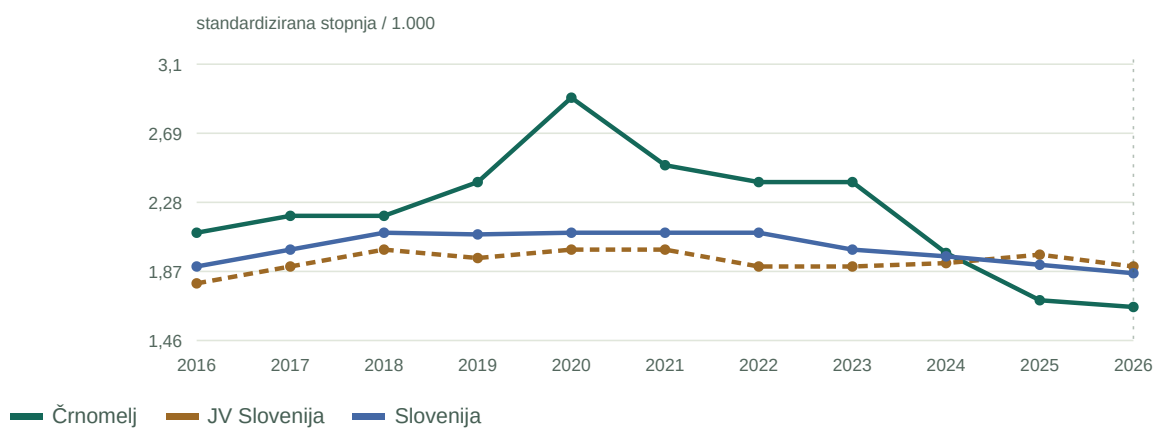
16

Kronične bolezni in umrljivost: trendi kazalnikov



Bolnišnične obravnave zaradi srčne kapi

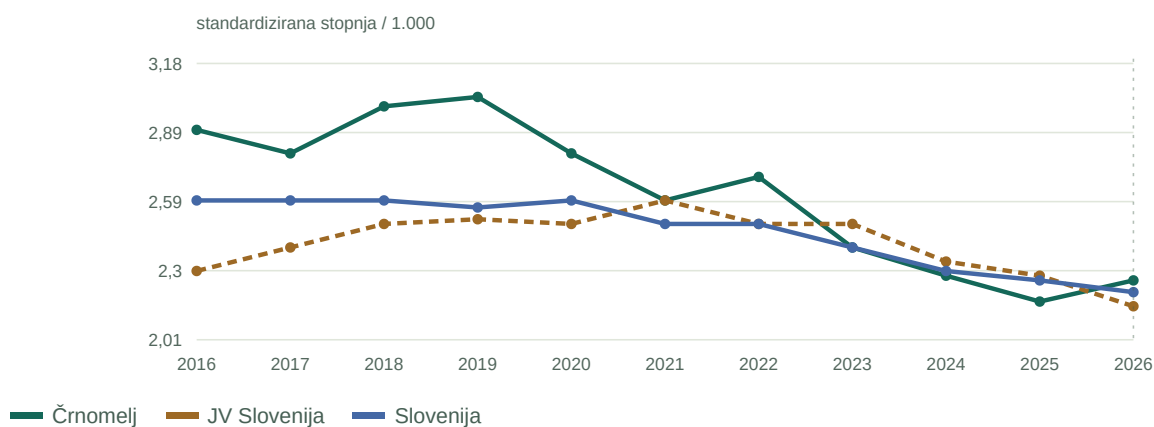
K4.8 · leto objave podatkov



Starost 35–74 let; zadnja izdaja je povprečje 2020–2024. [3]

Bolnišnične obravnave zaradi možganske kapi

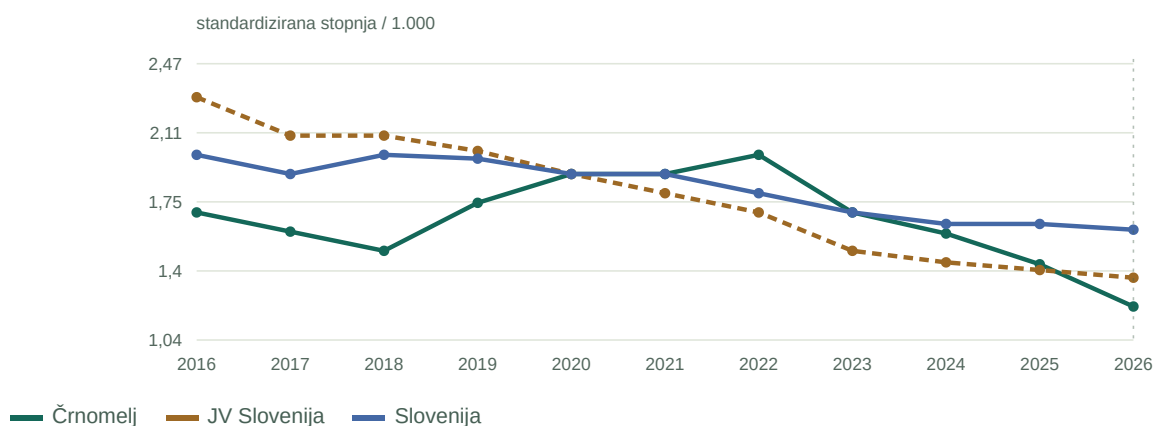
K4.9 · leto objave podatkov



Starost 35–84 let; 2026: 2,26 proti 2,21. Razlika ni statistično značilna. [3]

Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu

K4.4 · leto objave podatkov



Bolnišnične obravnave, starost 15+; zadnja izdaja je povprečje 2020–2024. [3]

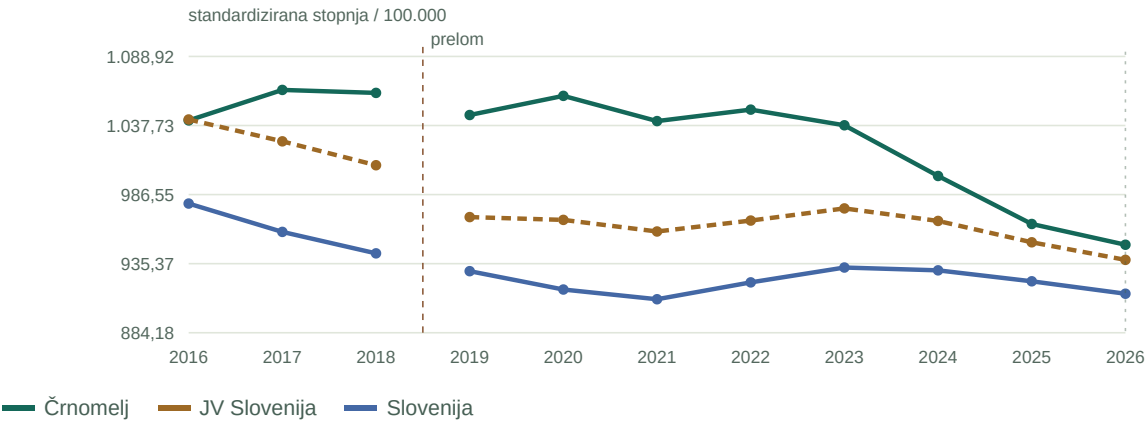
Stopnja prejemnikov zdravil za tlak ne meri vseh oseb s hipertenzijo in ne meri urejenosti njihovega tlaka. Del zdravil ima tudi druge indikacije. Znižanje uporabe zdravil zato ne sme postati samostojen cilj CKZ. [6] Pri bolnišničnih obravnavah zaradi alkohola neposredno pripisljivih bolezni je zadnja vrednost ugodnejša od slovenske, vendar občina tudi na začetku niza ni bila nad povprečjem. [3]

DRUGI PODATKI, IZDAJA 2026	ČRNOMELJ	SLOVENIJA	POMEN
Zdravila za sladkorno bolezen	5,72	5,47	Standardizirana stopnja na 100; ne celotna razširjenost bolezni.
Zdravila zaradi duševnih motenj	15,64	14,47	Standardizirana stopnja na 100; ne pomeni enakega deleža oseb z depresijo.
Bolniška odsotnost	19,17 dneva	20,53 dneva	Občina je pod povprečjem, a višje kot v izdaji 2016 (11,6 dneva).

Vir: [3][6]

Splošna umrljivost

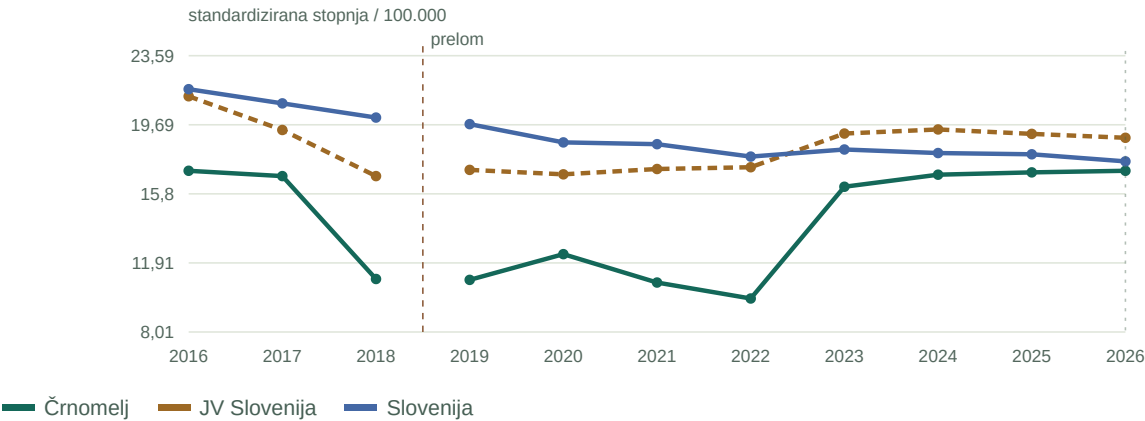
K5.1 · leto objave podatkov



Prelom 2018/2019: običajno → stalno bivališče. Zadnja izdaja: povprečje 2020–2024. [3]

Umrlijvost zaradi samomora

K5.7 · leto objave podatkov



Večletna povprečja; prelom bivališča 2018/2019. Zadnje obdobje 2020–2024. [3]

Splošna umrljivost je v izdaji 2026 številčno približno 4,0 % nad slovensko; NIJZ te razlike ne označuje kot statistično značilne. Primerjava od izdaje 2019 do 2026 kaže znižanje z 1.045,51 na 949,38 na 100.000. Pri

samomoru zadnja stopnja znaša 17,1 proti 17,63; majhne razlike in nihanja večletnih povprečij niso podlaga za ocenjevanje posamezne ustanove. [3][2]

PREZGODNJA UMRLJIVOST, 0–74 LET	ČRNOMELJ / SLOVENIJA	OBDOBJE
Bolezni srca in ožilja	70,0 / 62,8 na 100.000	Povprečje 2020–2024; standardizirano.
Vse vrste raka	141,9 / 140,9 na 100.000	Povprečje 2020–2024; standardizirano.

Točkovne ocene iz nizov; obe razliki sta v zadnjem profilu statistično neznačilni. [3][2]

17 CKZ: vidno delo, še ne celovito izmerjen učinek

Dopolnjeno 20. septembra 2026 · Kako izboljšati učinek: ukrepi in prvih 90 dni ↓ · Anketni list in predloge za spremljanje ↓

Center za krepitev zdravja je enota ZD Črnomelj. Uradna stran navaja vodjo **Tatjano Gregorič** in več strokovnih profilov: zdravstveno nego, fizioterapijo, prehrano, kineziologijo in psihologijo. Objavljena je telefonska številka 07 62 05 755 in naslov ckz@zd-crnomelj.si. Seznam oseb ne pove njihove zaposlitvene obremenitve. [51][4]

3,4 / 5

Javno dokumentirano delo

Ocena: dobro

Dejavnosti in strokovna sestava CKZ

Ocena priznava redno preventivno delo, terensko sodelovanje in javno dostopne kontakte. Znižujeta jo nepopoln pregled dosega in odsotnost celovite javne evalvacije rezultatov.

To je uredniška analitična ocena javnih dokazov, ne uradna akreditacija, klinična revizija ali lestvica slovenskih CKZ.

MERILO · ENAKA UTEŽ 20 %	OCENA	UTEMELJITEV
Kontinuiteta in raznolikost dejavnosti	4 / 5	Uradno poročilo navaja 100 % načrtovanih ur v osmih sklopih; dogodki in urniki potrjujejo raznovrstnost. Brez preglednice realizacije po delavnicah ni najvišje ocene. [5][52][53]
Ujemanje programa z zdravstvenimi potrebami	4 / 5	Prehrana, gibanje, duševno zdravje, kajenje in presnovna tveganja so vključeni. Ni dokazano, da intenzivnost in doseg zadoščata lokalnemu bremenu. [7]
Terensko delo in vključevanje	3 / 5	Dokumentirano delo v šolah, VDC ter zunaj mesta. Ni javnega imenovalca za delež doseženih ranljivih skupin, naselij ali novih uporabnikov. [54][55][56]
Javna komunikacija in kontakti	4 / 5	Vodja in strokovne osebe so navedene; objave segajo v 2026. Nekatera vabila so slikovna, zapisi razpršeni; potrebna sta enoten dostopen koledar in arhiv. [4][52][53]
Transparentnost dosega in izidov	2 / 5	Objavljena sta realizacija ur in rezultat manjše skupine. V pregledanih dokumentih ni celovitega prikaza različnih udeležencev, osipa, spremljanja po 6–12 mesecih in stroškov CKZ. [5]

Izračun: (4 + 4 + 3 + 4 + 2) / 5 = 3,4. Lestvica: 1 = v pregledanih virih ni uporabnih dokazov; 2 = posamični dokazi in velike vrzeli; 3 = dokumentirana izvedba z večjimi vrzelmi; 4 = več virov in dobro razvita izvedba, a nepopolno

merjenje; 5 = celovita, sledljiva izvedba in spremljanje. Ocena ni primerjalna: za druge centre nismo zbrali primerljivih podatkov.

Česa pošteno še ne ocenimo: klinične učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti in prispevka k spremembam občinske umrljivosti. Manjkajoči podatki niso dokaz slabega zdravljenja. Število člankov ali fotografij ni merilo zdravstvenega učinka.

Objavljeni rezultati skupine 17 udeležencev

KAZALNIK DRUŽINSKE OBRAVNAVE	OBJAVLJENI ŠTEVEC	PRERAČUN
Pridobljena mišična masa	14 / 17	82,4 %
Zmanjšana maščobna masa	13 / 17	76,5 % ; v izvorniku je napačno zapisano 79 %.
Znižan ITM	11 / 17	64,7 %
Razmerje obseg pasu / višina	8 izboljšanj + 3 ohranitve / 17	47,1 % izboljšanj; 64,7 % izboljšanj ali ohranitev.

Gre za samoporočane rezultate izvajalca, brez primerjalne skupine, velikosti sprememb, podatkov o vseh začetno vključenih in dolgoročnega spremljanja. Rezultat je spodbuden signal, ne dokaz 79-odstotne uspešnosti CKZ. Povečanje mišične mase samo zase, posebej pri rastočih otrocih, ne dokazuje učinka programa. [5]

Popravek kadrovskega podatka: tabela na str. 6 letnega poročila prikazuje **time** po dejavnostih. Postavke 1,00 za integrirani CKZ in 1,00 za družinsko obravnavo niso avtomatično en ali dva zaposlena za polni delovni čas. Prejšnji seštevek »2–3 FTE« je zato umaknjen. [5]

Kako bi CKZ lahko izboljšal svoj učinek?

Več ljudi pripeljati od prvega priporočila do trajne spremembe navad. Smiselna nadgradnja poveže dostop do programa s podporo pri vztrajanju in nadaljevanju po zaključku. Spodaj je izvedbeni predlog; najprej je treba preveriti, katere postopke CKZ že izvaja in kakšne zmogljivosti ima.

Predlagane izboljšave: izvedba, odgovornost in merilo uspeha		
IZBOLJŠAVA	KONKRETNA IZVEDBA IN NOSILEC	KAKO PREVERITI USPEH
Od napotitve do prvega obiska	CKZ in ambulanta ob primerni napotitvi ponudita konkreten termin; ob neudeležbi po dogovoru preverita razlog.	Delež napotenih, ki začnejo program, in čas do prvega obiska.
Odpraviti ovire za sodelovanje	CKZ preveri težave s prevozom, termini in skrbstvenimi obveznostmi. Z občino in KS glede na potrebe prilagodi urnik ali redno terensko izvedbo.	Doseg različnih oseb iz slabše doseženih skupin ter manj opuščanja zaradi ugotovljenih ovir.
Pomagati ljudem vztrajati	Strokovna ekipa z udeležencem določi izvedljiv osebni cilj, preverja napredek in ob težavah prilagodi podporo.	Dokončanje programa, razlogi osipa in napredek pri dogovorjenem cilju.
Podpora tudi po zaključku	CKZ dogovori nadaljnji stik ter po želji pomaga pri prvem obisku ustreznega društva ali redne vadbe. S partnerjem preveri sprejem, termin in stroške.	Dejanske vključitve in nadaljevanje dejavnosti po treh oziroma šestih mesecih.
Meriti trajnost izboljšanja	Ekipa za posamezni program izbere nekaj strokovno primernih kazalnikov ob začetku, zaključku ter po 6 in 12 mesecih.	Velikost spremembe in delež spremljanih; prikazati tudi neznane izide.

IZBOLJŠAVA	KONKRETNA IZVEDBA IN NOSILEC	KAKO PREVERITI USPEH
Prilagajati program rezultatom	Vodstvo in ekipa četrtno pregledata ovire, rezultate in porabljene ure ter prilagodita izvedbo.	Boljši dostop, dokončanje in trajnost rezultatov pri primerljivih skupinah.

Boljše merjenje mora voditi v boljšo podporo. Če se izkaže, da ljudje odnehajo zaradi dopoldanskih terminov, je ukrep sprememba urnika. Če po zaključku opustijo vadbo, je ukrep lažji prehod v redno skupino. To sta primera možnega odziva, ne ugotovljena vzroka osipa v Črnomlju.

NIJZ že opisuje zbiranje podatkov o obravnavah CKZ in poročanje prek eSZBO. Najprej je zato treba preveriti uporabnost obstoječih evidenc. Polletni rok oddaje podatkov ni dokaz šestmesečnega spremljanja zdravja posameznika. [57] Za povezovanje s partnerji že obstaja imenik CKZ *Povezani za zdravje*; pregled podpore je tudi v poglavju o društvih. [58]

Začetek: 90-dnevni preizkus v dveh obstoječih programih

OBDODBJE	NALOGA	REZULTAT ZA ODLOČANJE
Prvi mesec	Pregled evidenc in poti od napotitve do zaključka; preverba ovir pri udeležencih in osebju.	Izhodišče dosega, čakanja in osipa; seznam podatkov, ki že obstajajo.
Drugi mesec	V dveh programih preizkus dogovorjenega prvega termina in nadaljnega stika; prilagoditev ugotovljenim oviram.	Dokumentirana izvedba, odziv udeležencev in porabljene ure.
Tretji mesec	Pregled začetkov in osipa ter popravek izvedbe; dogovor nadaljnega spremljanja.	Odločitev o nadaljevanju preizkusa. Izidi po 6/12 mesecih še niso na voljo.

Številčne cilje izboljšanja je treba določiti po izhodiščnem popisu. Klinične cilje in ustreznost meritev določi zdravstvena ekipa. Pri otrocih se uporabijo starosti primerni kazalniki; uspeha ni smiselno presojati samo po padcu telesne mase.

Kaj potrebuje izvedba?

NALOGA	OKVIRNA POTREBA	MOŽEN VIR IN OMEJITEV
Koordinacija napotitev	Pilotno 2–4 ure tedensko.	Obstoječi program ZD, če kadri in pogodbeni obseg dopuščajo.
Prehod v podporno skupino	Pilotno 1–2 uri koordinacije tedensko; izvedba partnerja posebej.	Redni programi izvajalcev in morebitna občinska podpora društvom.
Vzpostavitev spremljanja	Okvirno 10–20 delovnih dni vzpostavitve in 1–2 dneva mesečno; kontrolni stiki posebej.	Organizacijska sredstva ZD; obseg zmanjšati, če obstoječe evidence že zadoščajo.
Dostopnost na terenu	Prostor, prevoz in ure izvedbe po izbranih lokacijah.	Občina in KS za dopolnila dostopnosti; zdravstveni del v programu ZD.

To so avtorske planske predpostavke, ne izmerjene potrebe, potrjen proračun ali zagotovljeno financiranje. Naloge se lahko prekrivajo. Pred odločitvijo je treba preveriti kadre in stroške.

Rezultate prikazati za vse vključene

V javnem pregledu je treba različne osebe ločiti od obiskov in navesti, koliko udeležencev je iz Občine Črnomelj. Objavijo se agregati; majhne skupine se združijo, da posameznikov ni mogoče prepoznati.

Izmišljeni primer prikaza; to niso podatki CKZ Črnomelj		
KORAK	ŠTEVILO LJUDI	RAZLAGA
Vključeni	100	Izhodiščna skupina.
Zaključili program	70	70 % vseh vključenih.
Spremljani po šestih mesecih	50	Pri polovici vključenih dolgoročni izid ostaja neznan.
Dokumentirano izboljšanje	35	70 % spremljanih oziroma 35 % vseh vključenih.

Ocena dokumentiranega dela ostaja 3,4/5. Predlog še ni izveden ukrep. Manjkajoče meritve niso avtomatično neuspeh, izboljšanje pri udeležencih pa brez primerjave še ne dokazuje vzročnega učinka CKZ. Nadaljnja širitev naj temelji na preverjenem dostopu in trajnosti rezultatov.

18 Anketni list in spremljanje napredka CKZ

Pripravljeni sta dve prazni predlogi: mesečni list za ekipo CKZ in kratek vprašalnik za odrasle udeležence. Skupaj povežeta dostop do programa, izkušnjo udeleženca, spremembo dogovorjene navade in konkretne izboljšave dela.

Dodano 22. septembra 2026 · različica 1.0 · neodvisni predlog za preizkus v dveh programih; uvedba v CKZ ni potrjena.

Najprej pregled obstoječih evidenc. NIJZ opisuje zbiranje podatkov med obravnavami in poročanje prek eSZBO. Polletna oddaja ni dokaz spremljanja posameznika po šestih mesecih. [57] Predloga dopolnjuje lokalni pregled; ni uradni obrazec NIJZ ali validirana zdravstvena lestvica. Spletna stran ne zbira odgovorov.

Kateri list uporabiti in kdaj		
GRADIVO	VSEBINA	RITEM IN ODGOVORNOST
List za ekipo	Osem meril: preglednost, dostop, ujemanje s potrebami, dokazi in izidi, pravičnost, stroški, trajnost ter izvedljivost. Za vsako ocena 1–5 ali »ni podatka / ni uporabno«, dokazilo in vrzel; ob koncu ukrep, odgovorna vloga, rok in cilj.	Ekipo mesečno; vodja CKZ četrtno preveri izvedbo ukrepov. Enake uteži 12,5 % pri vseh osmih ocenjenih merilih; pri delnem povprečju navesti n/8 in primerjati le ista merila.
Vprašalnik za udeleženca	Deset vprašanj o dogovorjeni navadi (dni v zadnjem tednu), zaupanju, ovirah, naslednjem koraku in podpori; razumljivost, zadovoljstvo in predlog izboljšave le ob zaključku. Možnost preskoka odgovora.	Pred začetkom, ob zaključku ter po 6 in 12 mesecih od referenčnega zaključka; predlagano okno ±30 dni. Tudi za udeležence, ki programa ne dokončajo, uporabiti predvideni zaključek njihove skupine.

GRADIVO	VSEBINA	RITEM IN ODGOVORNOST
Excelova predloga	Navodila, kazalniki s števci in imenovalci, obseg in parni izidi, samoocena ekipe ter dnevnik ukrepov. Prazna polja niso ničle. Odstotki se preračunajo ob odprtju v preglednici.	Pooblaščen vloga CKZ vnaša samo agregate; brez individualnih odgovorov. Pred objavo preveriti majhne skupine in možnost prepoznavne iz kombinacij podatkov.

Kaj naj pokaže četrletni pregled?

KAZALNIK	PRAVILO ZA POŠTEN PRIKAZ
Začetki, zaključki in različne osebe	Ločiti osebe, obiske in programe. Za začetek spremljati isto kohorto napoteni z vsaj 30 dnevi opazovanja; za zaključek samo kohorte z zapadlim predvidenim zaključkom. Letnih različnih oseb ne seštevati po mesecih.
Odziv po 6/12 mesecih	Odgovorili / vsi začetno vključeni, katerih kontrolno okno je že poteklo; prikazati tudi nezapadle, neodzivne in manjkajoče odgovore na posamezna vprašanja.
Sprememba navade in zadovoljstvo	Za isto osebo in isto navado parna razlika v dnevih na teden; število parov, mediana razlik in število brez para. Zadovoljstvo prikazati ločeno z odzivnostjo. Ni skupne »ocene zdravja« ali dokaza vzročnega učinka CKZ.
Dostop in stroški	Čakanje, ovire pri prevozu ali terminih in razlogi opustitve; porabljene ure ter pripisani stroški na začetnika oziroma zaključeni program iste kohorte. Navesti obračunsko metodo; to ni ocena stroškovne učinkovitosti.

Kaj še urediti

ROK IN UKREP	NOSILEC IN PLANSKI VIRI	PREVERJANJE KORISTI IN TVEGANJ
0–12 mesecev: slovar podatkov, koledar kontrol, preizkus razumljivosti ankete, papirna možnost in dnevnik ukrepov.	CKZ in skrbnik podatkov ZD; v okviru že predlaganih 10–20 dni vzpostavitve ter 1–2 dni mesečno, kontrolni stiki dodatno. Možna organizacijska sredstva ZD.	Po 3 mesecih čas izpolnjevanja in manjkajoči podatki; po 6/12 mesecih odziv in parne spremembe. Omejiti dvojni vnos in izključevanje oseb brez digitalnega dostopa.
1–3 leta: enoten koledar programov, zbirni prikaz rezultatov, preverjeni prehodi v podporne dejavnosti.	CKZ, ZD, občini in partnerji; plansko 60-minutni četrletni pregled ekipe, ure izvoza in partnerjev posebej. Možni redni programi oziroma dogovorjena dopolnila.	Letno preveriti dostopnost, dejanske vključitve in izide po 12 mesecih. Javnost vidi agregate; majhne skupine združiti ali prikriti tudi tam, kjer bi jih razkrili seštevki.
3–10 let: trajno spremljanje, nadomeščanje skrbnika podatkov in zunanja metodološka presoja.	Vodstvo ZD, strokovna podpora po dogovoru; letni načrt ur, cena zunanje presoje po opredelitvi obsega. Možna sredstva ZD ali upravičeni razvojni viri; razpis ni predpostavljen.	Letni pregled kakovosti; po 4 letih presoja trajnosti, dostopa in stroškov. Primerjava z drugimi centri šele ob enakih definicijah, programih in obdobjih.

Priprava na uporabo: CKZ določi odgovorno vlogo, obvestilo udeležencem, način povezovanja odgovorov in varovano hrambo. Šifrirani list za spremljanje iste osebe ni anonimna anketa; ključ in kontakti ostanejo ločeno pri CKZ. Javna stran ponuja prazne predloge. Zdravstvene meritve izbere strokovna ekipa po obstoječih protokolih.

Ocena javno dokumentiranega dela ostaja 3,4/5. Nova samoocena je ločeno orodje z osmimi merili in še nima rezultatov. Priprava obrazcev ni dokaz izboljšanja storitev. Lokalnih primerjalnih podatkov za to anketo še ni; cilje naj ekipa določi po začetnem trimesečnem pregledu.

19 Dejavnosti CKZ v objavah Radia Odeon

Pregled vključuje lokalni arhiv ter notranje iskanje Radia Odeon z izrazi CKZ, krepitev, ZVC, zdravstvenovzgojni in imenom vodje. Uporabljena je domena **radio-odeon.com**. Članki so sekundarni dokazi o dejavnostih; vsebina organizatorjev, objavljena v mediju, ni neodvisna klinična evalvacija.

OBSEG PREGLEDA	REZULTAT
Pregledane lokalne Markdown datoteke	4945
Pregledane spletne objave	1068
Objave z izrecno povezavo s CKZ Črnomelj	396
Od tega: vabila	246
Od tega: poročila / novice	128
Od tega: obvestila in preklici	22
Neuspešni zajemi ob zaključku	0

Enota popisa je **objava z enoličnim URL-jem**, ne posamezna izvedena delavnica. Ponavljajoča se vabila lahko napovedujejo isti program; en festivalski članek lahko opisuje več dejavnosti. Zajem in začetna razvrstitev celotnega registra sta avtomatizirana po izrecnih besedilnih pravilih; spodnji izbrani primeri so vsebinsko preverjeni. Pri mejnih primerih je potreben pregled shranjenega besedila. Zaradi nepopolnih datumov in arhiva ni utemeljeno trditi, da gre za vse dogodke v zgodovini CKZ. Celoten najdeni nabor je na voljo za pregled, vključno z izločitvami in nejasnimi primeri.

DATUM / DOKAZ	DEJAVNOST	KAJ PRIZNAMO CKZ IN KAJ OSTAJA NEZNANO
8. 9. 2020 Poročilo o odprtju	Odprtje pod imenom Center za krepitev zdravja Bela krajina. [59]	Dokumentiran institucionalni razvoj. Investicijska sredstva ob odprtju niso letni strošek centra.
6. 4. 2022 Objava 9. 4.	Izobraževanje uporabnikov VDC; napoved nadaljnje priprave obroka. [54]	Prilagojeno delo z uporabniki VDC; brez merjenja dolgoročnih sprememb.
20. 2. 2024 Objava 4. 3.	Naravoslovni dan PŠ Adlešiči. [56]	Dejavnost tudi na podružnični šoli; objava ne navaja celotnega letnega dosega.
8.–10. 4. 2024 Poročilo o izvedbi	Festival zdravja za otroke, odrasle in starejše. [60]	Medgeneracijski program na več lokacijah; ni primerljivih meritev pred in po festivalu.
12. 10. 2024 Objava 15. 10.	Rožnati koraki v Dobličah, približno 50 udeležencev. [61]	Konkreten lokalni doseg in partnerstvo. Samopregledovanje ne nadomešča organiziranega presejanja.
20. 3. 2025 Objava 25. 3.	Zobkovadba na OŠ Milke Šobar – Nataše. [62]	Praktična ustna higiena in prilagojeno delo; manjkajo spremljani kazalniki ustnega zdravja.
Objava 9. 4. 2025	Festival zdravja v Radencih: vadba, medgeneracijsko sodelovanje in meritve. [55]	Terenski doseg ob Kolpi; meritev brez nadaljnje obravnave še ni zaključen preventivni proces.
Objava 14. 5. 2025	Vitaminski dan v 6. razredu OŠ Dragatuš. [63]	Prehranska pismenost v šoli; ni dokaz trajne spremembe prehrane.

DATUM / DOKAZ	DEJAVNOST	KAJ PRIZNAMO CKZ IN KAJ OSTAJA NEZNANO
Objava 25. 11. 2025	Brkati pohod na Mirno goro; CKZ sodeluje z meritvami in preventivnimi vsebinami. [64]	Doseganje moških in partnerstvo; natančno število udeležencev v besedilu ni navedeno.
Objava 19. 3. 2026	Dan za zdrav nasmeh in dobre navade na OŠ Semič. [65]	Dokaz nadaljevanja šolskega dela v 2026; šteje v območje izvajanja CKZ, ne izključno v Občino Črnomelj.

Sklep pregleda: očitek, da CKZ ne dela na terenu, ne zdrži. Prav tako ne zdrži sklep, da veliko objav že dokazuje uspešno zmanjševanje bolezni. V registru so objave CKZ Metlika izločene iz ocene Črnomlja; pri mešanih dogodkih je treba preveriti dejansko vlogo posameznega centra.

20 Društva in podporna pomoč zunaj ambulanste

Pregled 15 društev, združenj oziroma njihovih lokalnih enot in povezanih točk, preverjen 20. septembra 2026. Vključuje redno gibanje, podporo pri kroničnih boleznih, duševnem zdravju, demenci in življenjskih stiskah.

Koristna obstoječa osnova: CKZ Črnomelj je že septembra 2025 izdal zbirnik *Povezani za zdravje* z lokalnimi kontakti. Smiselno ga je redno posodablјati in povezati z aktualnimi stranmi društev. To je dodatno potrjeno delo centra pri obveščanju; ocena dokumentiranega dela 3,4/5 ostaja, saj novi imenik ne meri zdravstvenih izidov. [58]

Šola zdravja: deset skupin v občini

Uradni občinski seznam društva navaja Črnomelj, Dragatuš, Kanižarico, Tančo goro, Vinico, Špeharje, Zilje, Svibnik, Adlešiče in Majer. Zadnje tri skupine so navedene z letom ustanovitve 2025. Urnik na Gričku ne velja samodejno za ostale skupine. [66]

»Objavljeno« pomeni navedbo v javnem viru, ne telefonske potrditve naslednjega termina. Pri organizacijah iz imenika 2025 je starost podatka posebej označena. Podporni programi dopolnjujejo zdravstveno obravnavo. Pogojev članstva, prispevkov in proste zmogljivosti ne domnevamo.

ORGANIZACIJA / POMOČ	KJE IN KAKO DO KONTAKTA	DOSTOPNOST IN VKLJUČITEV
Društvo Šola zdravja — Črnomelj in vaše skupine Redno skupinsko gibanje in druženje; možen partner za vzdrževanje gibalnih navad po obravnavi CKZ. [67][66]	Črnomelj: vzpetina v parku Griček; ponedeljek–sobota ob 7.30, razen praznikov. Lidija: 040 784 400; malesic.lidija@gmail.com	Lokalna skupina objavljena Termin je objavljen na strani skupine. Aktualno članarino, prilagoditve in možnost prvega obiska preveriti pri vodji; zneska iz 2024 ne prikazujemo kot veljavnega.
Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine Strokovno vodena vseživljenjska rehabilitacijska vadba in podpora koronarnim bolnikom. [68][69]	Zveza izrecno navaja Črnomelj med kraji vadbe; starejša objava društva potrjuje sodelovanje s CKZ v ZD. info@koronarnodrustvo-dbk.si; za povezavo s skupino tudi CKZ Črnomelj.	Vadba v Črnomlju navedena Pred vključitvijo preveriti ustrezno skupino, aktualni termin in prispevek. Starega urnika ponedeljek/sreda ne potrjujemo za 2026.

ORGANIZACIJA / POMOČ	KJE IN KAKO DO KONTAKTA	DOSTOPNOST IN VKLJUČITEV
Društvo diabetikov Metlika Izobraževanje o sladkorni bolezni, vrstniška podpora, pohodi in izmenjava izkušenj. [70][71]	Objavljeno vpisno mesto: Društvo upokojencev Črnomelj, Ulica 21. oktobra 15; pisarna društva v Metliki. slavo.prevalsek@siol.net	Dostopno tudi iz Črnomlja Vključuje tudi prebivalce širšega območja; dogovoriti se o članstvu, aktualnih srečanjih in stroških. Vpisno mesto ni diabetološka ambulanta.
Europa Donna Slovenija — skupina Bela krajina Podpora članicam ob zdravljenju raka dojk, skupnost, prilagojeni pohodi in druge aktivnosti. [72]	Prvi torek v mesecu ob 18.00, Ljudska univerza Črnomelj, Kolodvorska cesta 32c. Objavljena je tudi sezonska joga. Damjana Štefanič: 040 219 661; belakrajina@europadonna.si	Lokalna skupina objavljena Sprejemajo nove članice. Pred obiskom preveriti termin in pogoje posamezne aktivnosti; joga je navedena od oktobra do maja.
Metuljčica — skupina Črnomelj Samopomoč in izmenjava izkušenj ljudi z obolenji ščitnice. [73]	Drugi torek v mesecu ob 18.00, sejna soba Občine Črnomelj. Darinka Klemenčič: 040 251 649	Lokalna skupina objavljena Objavljen razpored nima datuma posodobitve. Termin preveriti; medsebojna podpora ne nadomešča zdravniškega spremljanja.
Klub Zeleni Jurij — Združenje bolnikov s CVB Povezovanje in podpora skupnost bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, tudi po možganski kapi. [74]	Zadnji četrtek v mesecu ob 17.00, Dom starejših občanov Črnomelj. Sonja Imširovič: 031 692 574; sonja.imsirovic@gmail.com	Lokalna skupina objavljena Pred prvim srečanjem potrditi termin, dostopnost in način vključitve; klub ni nadomestilo za predpisano rehabilitacijo.
OZARA Črnomelj Pisarna za informiranje in svetovanje na področju duševnega zdravja. Lokalno sodelovanje potrjuje Knjižnica Črnomelj. [75][58]	Črnomelj; aktualni naslov in urnik dogovoriti ob naročanju. 07 306 18 60; karmen.zunic@ozara.org	Lokalno delo potrjeno; kontakt iz 2025 Kontakt je iz imenika CKZ 2025; neposredna podstran OZARE ni bila dostopna. Obseg sedanje ponudbe preveriti.
Slovenska filantropija — Hiša Sadeži družbe Črnomelj Brezplačne medgeneracijske dejavnosti, zdravo staranje, druženje in vključevanje prostovoljcev. [76]	Železničarska cesta 5, Črnomelj; dejavnosti po mesečnem programu. 040 696 100; hisa-crnomelj@filantropija.org	Lokalni center z objavami 2026 Uradna stran navaja brezplačne aktivnosti; za nekatere je potrebna prijava. Gre za socialno in preventivno podporo.
RKS — Območno združenje Črnomelj Krvodajalstvo, prva pomoč in humanitarna podpora. [58]	Območje občin Črnomelj in Semič. 07 305 14 51; crnomelj.ozrk@siol.net	Lokalni izvajalec v imeniku CKZ Podatki iz zbirnika CKZ, september 2025. Preveriti posamezni program; stroški tečajev niso preverjeni.
Združenje multiple skleroze Slovenije — Dolenjska podružnica Povezava bolnikov z MS z regionalno podružnico in podporno mrežo. [77]	Podružnica izrecno vključuje Črnomelj, Metliko in Semič ter navaja poverjenico za Belo krajino. Darinka Filipčič: 041 391 762; podružnica: 041 212 863	Regionalno pokriva Črnomelj Pri poverjenici preveriti lokalna srečanja, programe in pogoje vključitve; spletna navedba območja ni potrdilo stalne ambulante.

ORGANIZACIJA / POMOČ	KJE IN KAKO DO KONTAKTA	DOSTOPNOST IN VKLJUČITEV
Spominčica – Alzheimer Slovenija in lokalna demenci prijazna točka Informacije in podpora ob demenci; usposabljanje svojcev in lokalnih organizacij. [78][79]	Ljudska univerza Črnomelj javno potrjuje demenci prijazno točko. LU je javni zavod, Spominčica pa združenje. Spominčica: 01 256 51 11; info@spomincica.si	Nacionalno združenje z lokalno povezavo Za informacije se je mogoče obrniti na lokalno točko; za skupino svojcev ali novo usposabljanje dogovor s Spominčico. Točka ni diagnostična ambulanta ali stalna oskrba.
Slovensko društvo Hospic — Dolenjska, Posavje in Bela krajina Spremljanje hudo bolnih in podpora svojcem ter žalujočim. [80][81]	Regionalni odbor v Novem mestu; pomoč v konkretnem okolju se dogovori individualno. 051 454 845; dolenjska@hospic.si	Regionalni odbor za območje Ob klicu preveriti možnost obiska in razpoložljivost podpore. Iz imenika ni mogoče obljubiti takojšnje ali 24-urne zdravstvene nege.
ŠENT — Dnevni center Novo mesto Individualni razgovori, pomoč pri urejanju zadev in dejavnosti dnevnega centra za duševno zdravje. [82]	Smrečnikova ulica 60, Novo mesto; uradno objavljen center, lokalna enota v Črnomlju ni potrjena. 030 767 702; amina.nur@sent.si	Možen regionalni partner Individualni razgovori po predhodni najavi. Sprejem prebivalcev Črnomlja, prevoz in morebitne terenske dejavnosti je treba posebej dogovoriti.
Sožitje Bela krajina Kontakt za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam. [58]	Bela krajina; aktualni programi v Črnomlju niso dodatno potrjeni. 031 515 412; drustvo_sožitje@t-2.net	Navedeno v lokalnem imeniku 2025 Predlagan partner za prilagojene programe; podrobni pogoji in zmogljivosti zahtevajo neposredno potrditev.
Društvo invalidov Črnomelj Kontakt invalidske organizacije; možen partner pri dostopnosti in prilagojenem vključevanju. [58]	Črnomelj; konkretnih zdravstvenih storitev s tem pregledom ne potrjujemo. 07 305 32 40; di.crnomelj@a1mail.si	Navedeno v lokalnem imeniku 2025 Najprej preveriti sedanjí program, dostopnost in članstvo. Vpis v imenik sam ne dokazuje izvajanja rehabilitacije.

Prenesi imenik CSV

Kako bi lahko sodelovali s CKZ in občino?

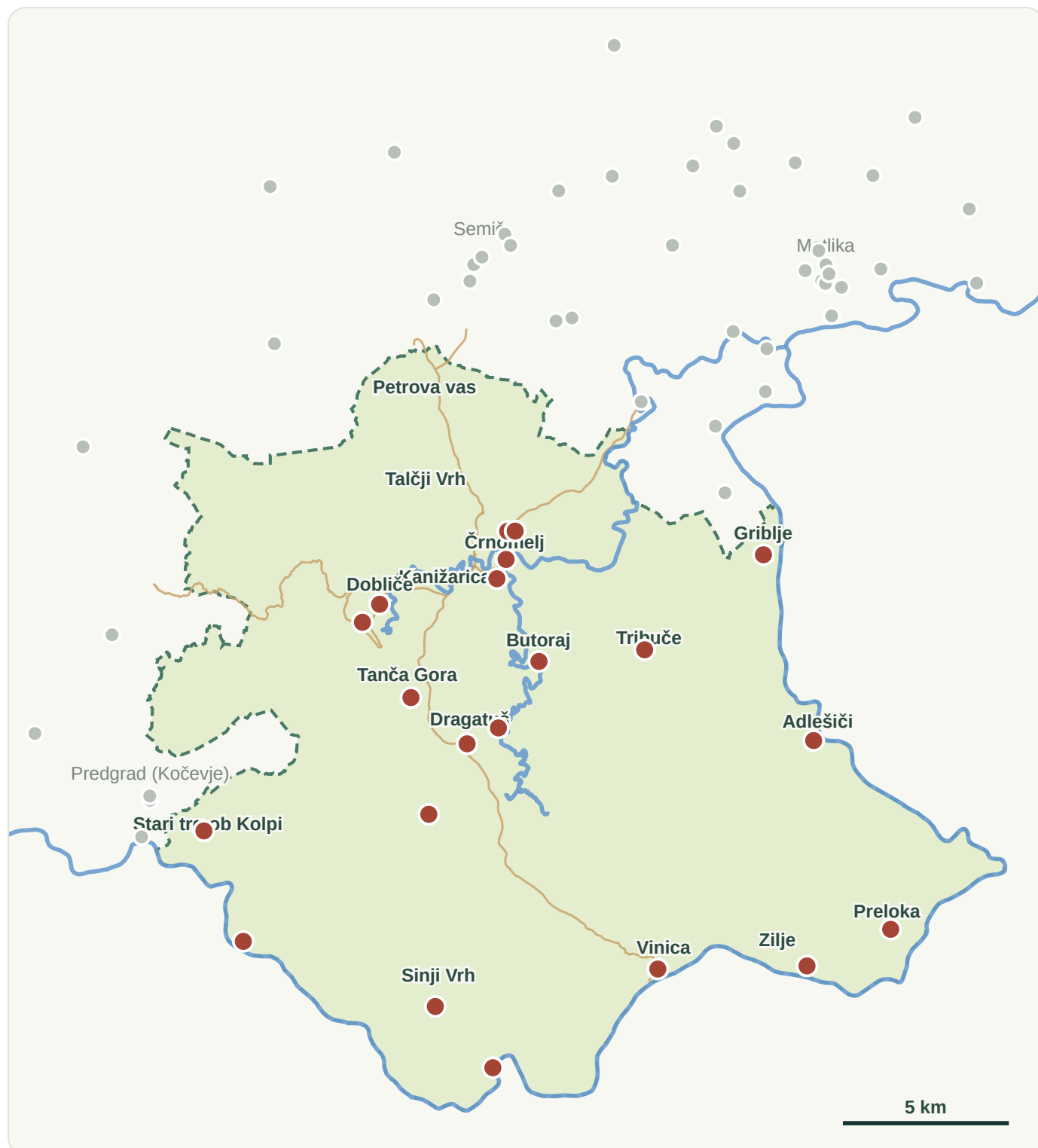
PREDLOG / ROK	NOSILCI IN SREDSTVA	KORIST IN PREVERJANJE
0–12 mesecev: preveriti kontakte ter uvesti pomoč pri prvem stiku po koncu obravnave CKZ; uporabnik sam izbere dejavnost.	CKZ in imenovani predstavniki društev. Planska ocena: 1–2 delovna dneva za prvi krog preverbe, nato mesečno vzdrževanje; obstoječe organizacijske ure.	Manj izgubljenih kontaktov. Merilo: aktualnost imenika in delež uporabnikov, ki so uspeli vzpostaviti stik; brez prenosa diagnoz društvom brez ustrezne podlage.
1–3 leta: poskusno povezati redno gibanje, podporne skupine in dostopne prevoze v odročnejših krajih.	Občina, CKZ, Šola zdravja in druga zainteresirana društva. Obseg določiti s popisom potreb; možni občinski razpisi in redni viri izvajalcev, brez zagotovljenega financiranja.	Kontinuiteta in doseg zunaj mesta. Tveganje: preobremenitev prostovoljcev. Merilo: vztrajanje po 3/6 mesecih in geografski doseg.
3–10 let: redno načrtovanje mreže skupaj z zdravstvenimi in socialnimi izvajalci.	Občina in izvajalci; večletni program po evalvaciji, z ločenim financiranjem strokovnih storitev in prostovoljskih dejavnosti.	Trajnost ob staranju prebivalstva. Merilo: nezadovoljene potrebe in uporabniška izkušnja; ne samo število dogodkov.

To so predlogi sodelovanja, ne že sklenjeni dogovori. Za oceno uspešnosti posameznega društva potrebujemo doseg, obseg dela, vire in rezultate; sam seznam kontaktov ne zadošča za pošteno številčno oceno.

21 Lokacije defibrilatorjev (AED) in dostopnost

Zemljevid prikazuje 67 lokacij avtomatskih zunanjih defibrilatorjev iz datoteke, ki jo je dodal naročnik poročila. Znotraj meje Občine Črnomelj jih je **21**; ostale so v sosednjih občinah in so prikazane zbledelo. **Vsi AED-ji v občini Črnomelj so javno dostopni.** Podatek o javni dostopnosti je dopolnjen po sporočilu naročnika z dne 23. 9. 2026.

[83]



Kako dobra je pokritost?

KAZALNIK	VREDNOST	POMEN
Defibrilatorji v datoteki	67	Datoteka zajema tudi sosednje občine (Metlika, Semič, Predgrad).
Znotraj meje Občine Črnomelj	21	Razvrščeno po meji občine iz OpenStreetMap, ne po naslovu.
Od tega v gasilskih domovih ali gasilskih vozilih	14 od 21	Tudi ti AED so javno dostopni; popravek naročnika z dne 23. 9. 2026.
Naselja (OSM) v občini z defibrilatorjem znotraj 1 / 3 / 5 km zračne črte	30 % / 85 % / 100 %	Od 111 naselij v občini, upoštevani so vsi defibrilatorji iz datoteke, tudi v sosednjih občinah; zračna razdalja, ne čas vožnje ali odzivnost reševalcev.
Naselja najdlje od najbližjega defibrilatorja	Bojanci (4.8 km); Rodine (4.4 km); Naklo (3.9 km); Nova Lipa (3.8 km); Rožanec (3.8 km); Stara Lipa (3.6 km)	Kandidati za preverjanje potrebe, ne dokaz vrzeli.

Omejitve. Javna dostopnost AED v občini Črnomelj je navedena po popravku naročnika. Pregled ne vključuje terenske preverbe delovanja naprav ali datumov servisa. Podatek o javni dostopnosti ne opredeljuje dostopa 24 ur na dan. Za AED v sosednjih občinah s tem popravkom dostopnost ni določena. Razdalje so zračne in ne upoštevajo terena ali cest. Ob srčnem zastoju najprej pokličite 112; reševalec lahko usmeri do najbližjega defibrilatorja.

► Seznam vseh 67 lokacij (iskanje in prenos)

22 Raziskave o dejavnikih zdravja in omejitve lokalnih sklepov

Znanstvena literatura pomaga izbrati ukrepe. Ne dokazuje, da je določen dejavnik glavni vzrok prav v Črnomlju. Lokalno vzročnost bi morali preveriti z dodatnimi podatki o prehrani, gibanju, dostopnosti in poteku obravnave.

PROBLEM IN MEHANIZEM	RAZISKAVA / MOČ DOKAZA	UPORABNA POSLEDICA IN OMEJITEV
Prekomerna prehranjenost otrok. Hrana, gibanje, spanje, psihosocialne okoliščine in biologija delujejo skupaj.	Slovenska nerandomizirana raziskava več kot 34.000 sodelujočih in primerjalne skupine: 2–3 dodatne šolske ure gibanja tedensko; največja razlika v ITM po 3–4 letih. [84]	Reden večletni šolski program ima boljšo dokazno podlago kot pričakovanje spremembe po enkratnem dogodku. Izbira udeležencev lahko vpliva na rezultat; konkretnega učinka v Črnomlju ne napovemo.

PROBLEM IN MEHANIZEM	RAZISKAVA / MOČ DOKAZA	UPORABNA POSLEDICA IN OMEJITEV
Prehransko okolje. Dostopna in hitro zaužita hrana lahko poveča energijski vnos.	Hall in sod.: randomizirana navzkrižna bolnišnična raziskava 20 odraslih, po dva tedna na vsaki prehrani; ob ultra predelani prehrani približno 508 kcal/dan več. [85]	Smiselna je sprememba ponudbe hrane. Majhna kratka raziskava odraslih ni neposredna ocena otroške prehrane v Beli krajini.
Tveganje za sladkorno bolezen tipa 2. Presežna masa in neaktivnost sta spremenljiva dejavnika.	DPP: randomiziranih 3.234 odraslih z visokim tveganjem; intenziven življenjski program je v povprečno 2,8 leta zmanjšal pojavnost bolezni za 58 % relativno proti placebo. [86]	Prednost imajo strukturirana obravnava, nadaljnji stiki in spremljanje. Rezultat ne pomeni 58-odstotnega zmanjšanja bolezni v celotni občini ali po eni delavnici.
Visok tlak in srčno-žilni zapleti. Zdravljenje urejenega tlaka zmanjšuje tveganje.	SPRINT: randomiziranih 9.361 oseb z večjim srčno-žilnim tveganjem brez diabetesa; intenzivna obravnava je zmanjšala primarni sestavljeni izid, a povečala nekatere neželene dogodke. [87]	CKZ lahko podpira merjenje in sodelovanje pri zdravljenju; cilje in terapijo določa zdravnik. Univerzalni cilj pod 120 mmHg iz te študije ni primeren za vse prebivalce.
Alkohol in promet. Vplivajo dostopnost, cena, družbene norme in vožnja po pitju.	WHO SAFER povezuje omejevanje dostopnosti, ukrepe proti vožnji pod vplivom, kratke intervencije/zdravljenje, omejitve oglaševanja in cenovne ukrepe. [88]	Lokalno povezati ZD, policijo, občino in organizatorje prireditev. Davki in večina regulacije so državni ukrepi; vinorodnost sama ni dokaz lokalnega vzroka.
Kajenje. Zasvojenost zahteva trajnejšo podporo kot informiranje.	Klinične smernice WHO 2024 obravnavajo vedenjsko podporo in zdravljenje opuščanja tobaka. [89]	Vzpostaviti prehod od svetovanja do obravnave ter preverjati abstinenco po 6 in 12 mesecih; izbiro zdravljenja vodi zdravstveni strokovnjak.
Duševne stiske in samomorilnost. Preplet socialnih tisk, bolezni in življenjskih dogodkov.	WHO LIVE LIFE: zgodnje prepoznavanje in spremljanje, življenjske veščine mladih, odgovorno medijsko poročanje ter varnejše okolje. [90]	Povezati CKZ, družinsko medicino, šole, CSD in specialistično pomoč. Delavnica sproščanja ne nadomesti zdravljenja težje duševne motnje.
Neenak dostop. Stroški, prevoz, delovni čas, izobrazba in bivanjske razmere omejujejo možnosti.	WHO, World report on social determinants of health equity, 2025. [47]	Meriti ovire po naseljih in uporabniških skupinah. Udeležbe ne razlagati samo kot »osebno motivacijo«; učinka posamezne ovire lokalno še ne poznamo.

Predavanja in strokovna gradiva za izvajalce

GRADIVO	KAJ JE BILO PREVERJENO	UPORABA
WHO / UNICEF / World Obesity Federation: <i>Accelerating childhood overweight reduction</i> , 21. 11. 2024. [91]	Prebrane spremljevalne prosojnice, zlasti str. 7–8 in 15–19: več vzrokov, preprečevanje stigme, šolsko okolje in financiranje. Video ni bil v celoti pregledan. [92]	Skupni strokovni sestanek CKZ, šol in občine; pripraviti lokalni načrt po odgovornostih. Globalni cilji za otroke pod 5 let niso isti kazalnik kot NIJZ za šolske otroke.
WHO: predstavitev smernic za zdravo šolsko prehransko okolje, 27. 1. 2026. [93]	Preverjena uradna objava z video povezavo in opisom smernic; uporabljena objavljena vsebina o ponudbi, pravilih in spodbudah pri izbiri hrane. [94]	Pregled šolskih jedilnikov, ponudbe pijač in dostopnosti vode; spremembo ponudbe povezati z izobraževanjem.

Predavanja so dopolnilna strokovna razlaga. Ocene učinkov v zgornji tabeli izhajajo iz raziskav, ne iz promocijskih opisov webinarjev.

23 Načrt ukrepov za eno leto, mandat in desetletje

To je **predlog**, ne že sprejet program ali zagotovljeno financiranje. Obseg dela je planska ocena avtorja; pred proračunsko odločitvijo je treba preveriti zmogljivosti, cene in upravičenost financiranja. Financiranje rednega zdravstvenega programa je treba ločiti od občinskih dopolnil in investicij.

0–12 mesecev

Urediti poročanje, ugotoviti ovire in uvesti ciljne pilote.

1–3 leta

Razširiti redno obravnavo in preveriti izide udeležencev.

3–10 let

Vzdrževati šolske programe, dostopno oskrbo in zdravo okolje.

ROK IN UKREP	NOSILEC / OCENJENI VIRI / MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev: javni letni pregled CKZ. Po programih prikazati vključitve, različne uporabnike, zaključke, osip, spremljanje in stroške; objaviti enoten koledar.	Vodja CKZ, vodstvo in računovodstvo ZD. Ocena: 10–20 delovnih dni vzpostavitve ter 1–2 dneva mesečno. Možen vir: obstoječa organizacijska sredstva zavoda, ob preverbi pogodbenih obveznosti.	Preglednost in boljše usmerjanje. Tveganje: dvojno štetje, obremenitev osebja in razkritje majhnih skupin. Merilo: prva preglednica v 6 mesecih, četrletne posodobitve; objava zgolj agregatov.
0–12 mesecev: pilot za otroke. Na dveh šolah povezati dodatno gibanje, prehransko okolje in družinsko obravnavo. [84][94]	Šoli in ustanoviteljica, CKZ kot strokovna podpora. Ocena: 2 dodatni šolski uri na skupino tedensko, koordinacija, jedilniki. Možno: šolski/občinski program in ustrezni nacionalni razpisi; brez domneve, da razpis že obstaja.	Redna izpostavljenost učinkovitejšemu okolju. Tveganje: izključitev otrok brez prevoza, stigmatizacija. Merilo: izvedene ure, udeležba in izhodiščni SLOfit; zdravstvenega učinka še ne pričakovati po enem mesecu.
0–12 mesecev: dostop do cepljenja in podpore na domu. Preveriti nepopolno cepljene otroške kohorte ter čakalne seznime/ovire za oskrbo starejših. [2]	Pedriatrija in patronaža; občina, CSD, izvajalec pomoči na domu. Ocena: 5–10 dni analize za vsak sklop, nato dogovorjen obseg dela. Možno: redni zdravstveni in socialni programi.	Odpraviti zamujene priložnosti. Tveganje: mešanje različnih storitev in upravičencev. Merilo: objavljena izhodišča ter vzroki neodziva; ločeno spremljanje cepljenja in oskrbe.

ROK IN UKREP	NOSILEC / OCENJENI VIRI / MOŽNO FINANCIRANJE	KORIST, TVEGANJE IN MERILO USPEHA
0–12 mesecev: alkohol in promet. Povezati kratke intervencije, usmerjanje v zdravljenje, preventivo na prireditvah in prometni nadzor. [88]	ZD/CKZ, občinski svet za preventivo v prometu, policija, organizatorji. Ocena: 4 usklajevalni sestanki letno in 1 ciljana akcija četrletno. Možno: redni programi in občinska preventiva.	Manj škodljivega pitja in tveganih voženj. Tveganje: samo medijska akcija brez obravnave. Merilo: število obravnav z nadaljnjim stikom; policijska letna poročila, ne zgolj delež iz petletnega kazalnika.
1–3 leta: redne skupine za presnovno in duševno zdravje. Zdravstveno utemeljene napotitve, programi z več srečanji in spremljanje po 6/12 mesecih. [86][87][89][90]	CKZ, družinska medicina, psihološka in specialistična obravnava. Ocena: začetno 4 kohorte letno; dejansko velikost in ure določi strokovna ekipa. Možno: pogodbeni program ZZS, dopolnitve po odobrenem načrtu.	Vzdrževanje sprememb in urejenost bolezni. Tveganje: osip, izbiranje lažjih primerov, neželeni učinki. Merilo: delež spremljanih od vseh vključenih; tlak po individualnem cilju, vzdrževanje sprememb, funkcionalnost in počutje.
1–3 leta: redne terenske točke in prevoz. Termine povezati s potrebami oddaljenih naselij, starejših in oseb z oviranostmi.	Občini Črnomelj in Semič, KS, CKZ, partnerji. Ocena: pilot 1 terenskega dne mesečno; prevoz in koordinacija posebej. Možno: redni terenski program in občinska dopolnila.	Lažji dostop in več novih uporabnikov. Tveganje: preusmerjanje omejenih kadrov brez dodatnega dosega. Merilo: različni uporabniki po območjih, razlogi neudeležbe, strošek na zaključen program.
3–10 let: trajno šolsko gibanje in varne poti. Po pilotu razširiti program ter izboljšati dostop do pešpoti, rekreacije in pitne vode. [84][94]	Občina, šole, upravljavci prostora in CKZ. Ocena: večletne pedagoške ure; investicije šole po popisu poti in projektantski oceni. Možno: občinski načrt razvojnih programov in ustrezni državni/EU razpisi.	Dolgoročno bolj zdrave navade in manj razlik v dostopu. Tveganje: vzdrževanje, prometna varnost, menjava prioritet. Merilo: trajnost programa po 4 letih; fitness in prehranjenost otrok po primerljivi metodi, raba poti in varnost.
3–10 let: podpora staranju in stalnost kadrov. Povezati pomoč na domu, demenci prijazne točke ter načrt pridobivanja in ohranjanja zdravstvenih kadrov.	ZD, občina, socialni izvajalci, šole za zdravstvene poklice. Ocena: letni kadrovski in storitveni načrt; obseg financ po analizi potreb. Možno: redni viri zdravstva/sociale in občinska podpora v okviru pristojnosti.	Kontinuiteta oskrbe in razbremenitev svojcev. Tveganje: pomanjkanje kadra, nepovezane storitve. Merilo: čakanje, nezadovoljene potrebe, stabilnost ekip in kakovost življenja uporabnikov.

Kako vemo, da ukrep deluje?

Pred začetkom določiti izhodišče in glavne izide. Poročati o vseh vključenih, ne le o uspešnih zaključkih. Kadar je izvedljivo, primerjati podobne šole oziroma postopno uvajanje programa; preveriti razlike v izhodiščih in osip. Po 6–12 mesecih spremljati vedenje in zdravstvene kazalnike udeležencev, po 3–4 letih šolske trende, po daljšem obdobju širše zdravstvene izide. To je predlog evalvacije; vpliva CKZ na umrljivost s preprosto primerjavo »pred in po« ne moremo dokazati.

24 Slovenija in EU: primerjava zdravstvenih kazalnikov

Profil OECD/European Observatory 2025 zagotavlja primerjavo Slovenije in EU. Občinskih kazalnikov ne postavljamo v isto lestvico, kadar se razlikujejo definicija, starost, leto ali standardizacija. [36]

KAZALNIK	SLOVENIJA	EU	OPOMBA
Dnevno kajenje, odrasli	17 %	19 %	2019; to ni isti kazalnik kot lokalni delež vseh kadilcev.
Debelost odraslih	18 %	15 %	2022; ITM ≥ 30 . Ne primerjati z lokalno prekomerno prehranjenostjo, ki vključuje preddebelost.
Zdravniki na 1.000 prebivalcev	3,5	4,3	2023; država kot celota, ne kadrovska zasedba ZD Črnomelj.
Pričakovana življenjska doba	82,3 leta	Slovenija je nad povprečjem EU.	2024; občinskega rezultata iz tega ni mogoče izpeljati.
Neizpolnjene zdravstvene potrebe	4,6 %	3,6 %	2024; med ljudmi, ki so imeli potrebo po oskrbi; pomemben razlog je čakanje.

Vir: profil 2025, poglavja Health in Slovenia, Risk factors, The health system in Accessibility. [36] Podatki niso dokaz velikosti lokalne vrzeli. Prejšnja trditev o »najvišji stopnji samomorov v EU« je umaknjena; neusklajene stopnje iz različnih virov niso uporabljene za lokalno evropsko razvrstitev.

25

Dvanajst vprašanj za odgovorne

ZA KOGA	VPRAŠANJE IN ZAHTEVANI DOKAZ
1 · Vodja CKZ	Koliko različnih ljudi je CKZ obravnaval v 2025 in koliko do presečnega datuma 2026, ločeno od števila obiskov?
2 · CKZ in ZD	Kakšna je realizacija po posameznih programih glede na načrtovane skupine, ure in udeležence?
3 · Vodstvo ZD	Koliko dejanskih zaposlenih in ekvivalentov polnega delovnega časa je namenjenih CKZ po poklicih?
4 · Računovodstvo ZD	Kakšni so letni neposredni in razporejeni stroški CKZ ter prihodki po virih financiranja?
5 · CKZ	Koliko ljudi je družinsko obravnavo začelo, zaključilo in opravilo kontrolno meritev; kako pojasnujete 13/17 = 79 %?
6 · CKZ in NIJZ	Kateri standardizirani izidi se spremljajo po 6 in 12 mesecih in ali lahko objavite agregate brez osebnih podatkov?
7 · Občina in CKZ	Katera naselja in skupine imajo najslabši dostop ter s čim boste ocenili ovire pri prevozu in terminih?
8 · Šole in ustanoviteljica	Koliko dodatnih ur gibanja je na voljo vsem otrokom in ali prevoz oziroma strošek komu preprečujeta udeležbo?
9 · Pediatrija	Kateri razlogi pojasnjujejo 44,4-odstotno precepljenost proti pnevmokokom v prikazani kohorti in kako boste preverili zamujene odmerke?
10 · Občina in socialni izvajalec	Ali nizek delež pomoči na domu izhaja iz manjših potreb, cene, kadrov ali čakanja; kakšen je popis potreb?
11 · ZD in policija	Kako povezujete obravnavo tveganega pitja, prometno preventivo in spremljanje ponavljajočih se kršitev brez nedovoljenega povezovanja osebnih evidenc?
12 · Svet zavoda in občini	Kdaj boste obravnavali javni letni pregled CKZ in kdo bo neodvisno presodil doseganje ciljev po štirih letih?

26 Popravki, omejitve in sled sprememb

Prejšnja izdaja je shranjena v lokalnem arhivu. Prenova ohranja izvirne številčne nize, popravlja njihovo razlago in dodaja novo dokazno podlago.

PREJŠNJA NAVEDBA	POPRAVEK IN PODLAGA
AED pri gasilskih domovih, podjetjih in zasebnih lokacijah morda niso dosegljivi; dostop naj bi bil odvisen od gasilcev.	23. 9. 2026: vsi AED-ji v občini Črnomelj so javno dostopni, po popravku naročnika. Vrsta lokacije ni dokaz omejenega dostopa. Popravek ne določa ur dostopa ali stanja naprav in ne zajema sosednjih občin. [83]
Zaključna opomba je celoten pregled omejevala na 19. 9. 2026.	Datum velja za osnovni pregled in register; tematske dopolnitve so posebej datirane. Dne 22. 9. 2026 dodane prazne predloge spremljanja, brez novih rezultatov CKZ; ponovno preverjen opis NIJZ. [57]
Vodja CKZ ni javno znana; približno 2–3 FTE.	Vodja je javno imenovana. Pogodbeni tim ni zaposleni oziroma FTE. [4][5]
Otroška prehranjenost je edini dosleden zaostanek in se ni izboljšala.	31,1 → 28,3 %; napredek ob vztrajni vrzeli. Več drugih kazalnikov je prav tako dosledno nad povprečjem. [3]
Koeficient razvitosti je vedno 0,90; delovna aktivnost šele 2026 nad povprečjem.	Razpon 0,87–0,91; delovna aktivnost nad slovensko že 2019. [3]
Nesreče z alkoholom so se skoraj prepolovile.	18,9 → 12,94 %, približno –31,5 %. [3]
Tri bolezni so iz nadpovprečja trajno prešle pod povprečje.	Možganska kap v zadnji izdaji 2,26 proti 2,21; alkoholne bolezni že 2016 pod slovensko stopnjo. [3]
Umrljivost ima neposredno primerljiv desetletni trend; odstopanje pojasni staranje.	Prelom metodologije 2018/2019; stopnje so že starostno standardizirane. [6]
13/17 pomeni 79 % uspešnost.	Izvirni vir vsebuje računsko napako: 76,5 %. Poleg tega ni znan trajni učinek. [5]
Slovenija ima najvišjo stopnjo samomorov v EU.	Neuporabljena trditev; za razvrstitev potrebujemo usklajeno leto, definicijo in standardno populacijo.

Odprto: popolna evidenca dogodkov CKZ, nedvoumni datumi starejših koledarskih vabil, primerljivi podatki drugih centrov, stroški in dolgoročni izidi uporabnikov. Javni register beleži stanje spletnih strani ob dostopu in ne more nadomestiti izvajalčeve evidence. Osnovni pregled in register objav imata presek 19. 9. 2026; poznejše tematske dopolnitve imajo naveden svoj datum (kader in šport 21. 9., obrazci CKZ in ponovna preverba strani NIJZ o spremljanju 22. 9., javna dostopnost AED 23. 9. 2026).

Literatura (IEEE)

Viri so oštevilčeni po prvem pojavu. Vsak uporabljeni spletni vir ima lokalno kopijo oziroma shranjen uporabljeni izvleček; bibliografski naslovi ostajajo v jeziku izvirnika.

[1] »Črnomelj | Zdravje v občini | NIJZ,« NIJZ, 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://obcine.nijz.si/obcine/crnomelj/17/2026/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

- [2] »Zdravje v občini 2026: Črnomelj,« NIJZ, 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://obcine.nijz.si/api/files/c49f9ba8760c194efdfc379c907674b2edc51334/data>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [3] »Časovni nizi kazalnikov za Črnomelj, izdaje 2016–2026: 54 Excelovih datotek,« NIJZ, 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://obcine.nijz.si/obcine/crnomelj/17/2026/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Lokalni izvirniki XLSX; izvoz v podatki/nijz/kazalniki.csv. Leto v nizu pomeni leto objave.
-
- [4] »Kontakti Centra za krepitev zdravja Črnomelj,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/ckz/predstavitev/kontakti/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [5] »Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2025,« ZD Črnomelj, 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2026/03/Letno-porocilo-ZD-Crnomelj-2025.pdf>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [6] »Zdravje v občini 2026 — Opisi kazalnikov,« NIJZ, marec 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://obcine.nijz.si/vsebine/metodoloska-pojasnila/opisi-kazalnikov-2026-223/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran lokalni izvirnik: str. 8–9, 19–20, 66–67, 96–97 in 108–109 (natisnjene strani).
-
- [7] »Finančni načrt in program dela za leto 2025,« ZD Črnomelj, 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2025/04/FINANCNI-NACRTI-2025.pdf>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [8] »Finančni načrt in program dela ZD Črnomelj za leto 2026,« ZD Črnomelj, 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2026/06/FINANCNI-NACRTI-2026-ZD-Crnomelj.pdf>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [9] »Dispanzer za mentalno zdravje,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/dispanzer-za-mentalno-zdravje/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [10] »Kontakti CKZ,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/ckz/predstavitev/kontakti/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [11] »Ambulante,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/?services=ambulante>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [12] »Zdravljenje v domu,« DSO Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.domcrnomelj.si/sl/zdravljenje/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [13] »Psihiatrična ambulanta,« ZD Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.zd-metlika.si/ambulante/psihiatricna-ambulanta/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [14] »V stiski nismo sami – starejši imenik,« OŠ Podzemelj / Zavod Metlika, 2023. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.ospodzemelj.si/files/2023/03/Zlozenka-ZAVODA-METLIKA-na-koga-se-lahko-obrnemo.pdf>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [15] »Odsotnost zdravnikov – september 2026,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/odsotnost-zdravnikov/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-

- [16] »Darinka Jerčinovič,« Mojpsihoterapevt.si – profil izvajalke, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.mojpsihoterapevt.si/psihoterapevt/Darinka-Jercinovic-185>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [17] »Fizioterapija,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/fizioterapija/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [18] »DSO Črnomelj 2025: kadrovska tabela, str. 43–44,« DSO Črnomelj, 2026 (poročilo za 2025). [Na spletu]. Dostopno: https://www.domcrnomelj.si/docs/porocanje/Letno_porocilo_z_obrazlozitvami_2025.pdf. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [19] »Trenerji Sportas,« Sportas, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.yousportas.si/trenerji/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [20] »Naše poslanstvo in ekipa,« RC Simon, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://rcsimon.si/nase-poslanstvo/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [21] »Jahalna šola in ekipa,« Horse Resort Stariha, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://horse-resort-stariha.si/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [22] »Rekreativni center Simon,« RC Simon, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://rcsimon.si/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [23] »Don Vito Gym Črnomelj,« Don Vito Gym, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.donvitogym.si/crnomelj.html>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [24] »Sportas studio,« Sportas, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.yousportas.si/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [25] »Osebno trenerstvo,« RC Simon, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://rcsimon.si/osebno-trenerstvo/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [26] »MD Rehab Lab,« MD Rehab, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://mdrehablab.com/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [27] »Rok Žagar – lokacija izvajanja,« Klinika Optimum, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.klinikaoptimum.si/o-nas/rok-zagar>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [28] »Ekipa in lokacija Rehab Studio,« Rehab Studio, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://rehabstudio.si/o-nas/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-
- [29] »Aktivni zdravniki ZZZS: preverjeni izveček za Črnomelj in Semič,« ZZZS, 1. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://partner.zzzs.si/zzzs-api/prenesi-datoteko?stdatoteke=14295&tx_agzzzsapi_izvajalcidownloadfile%5Baction%5D=downloadfile&tx_agzzzsapi_izvajalcidownloadfile%5Bcontroller%5D=Izvajalci&type=1249058992&cHash=4c02aa16fb75ac78f33edb132adf897e. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.
-

[30] »Zdravstvena postaja Vinica,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/zdravstvena-postaja-vinica/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[31] »Ambulanta Suzane Milenković,« Medicina MS, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://medicina-ms.si/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[32] »Ordinacija dr. Vuković,« Ordinacija dr. Vuković, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://vukovic.pro/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[33] »Splošna medicina,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/blog/doctors/splosna-medicina/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[34] »Staffing levels for European healthcare – poročilo 2026,« Evropska komisija, 2026. [Na spletu]. Dostopno: https://health.ec.europa.eu/document/download/b76a01d9-a2e9-4a59-aca7-9476ed908746_en?filename=hspa_eg-staffing-levels_rep_en.pdf. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[35] »Health at a Glance: Europe 2024,« Evropska komisija in OECD, 2024. [Na spletu]. Dostopno: https://health.ec.europa.eu/document/download/1e23af78-d146-4c84-be77-690fc6044655_en?filename=2024_healthatglance_rep_en.pdf&prefLang=es. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[36] »Slovenia: Country Health Profile 2025,« OECD / European Observatory, 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/country-health-profile-2025-country-notes_7e72146d/slovenia_27d174ae/4765833c-en.pdf. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[37] »Športni dan 1. triade, 14. 9. 2025,« OŠ Loka Črnomelj, 14. september 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.os-loka-crnomelj.si/2025/09/14/sportni-dan-1-triade/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[38] »Rokometni klub Črnomelj,« RK Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.rkcrnomelj.si/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[39] »Lipkomanija in vpis na treninge,« KK Kolpa Črnomelj, objavljeno na Radiu Odeon, 24. september 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/sport/lipkomanija-v-crnomlju-in-semicu/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[40] »Krajevna skupnost Črnomelj,« Občina Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://crnomelj.si/sl/o-obcini/krajevne-skupnosti/2021122908384865/crnomelj/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[41] »Teniški klub Loka,« TK Loka, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.tk-loka.si/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[42] »Ju-jitsu – o nas,« ŠD Ninja Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://ninjacrnomelj.wixsite.com/ju-jitsu/o-nas>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[43] »Klub praktičnega streljanja Črnomelj,« KPS Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://kpscrnomelj.si/klub>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[44] »Napoved dogodkov, september 2026,« Občina Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://crnomelj.si/sl/za-obcane/dogodki/>. [Dostopano: 21. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[45] »Predložena zbirka 43 poti GPX – manifest izvirnikov,« Naročnik poročila; izvirni avtorji niso potrjeni, obdelava 21. september 2026. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Izvirniki v viri/gpx; kontrolne vsote v manifestu. Popolnost in terensko stanje nista potrjena.

[46] »Meja Črnomlja, točke krajev in kartografska podlaga,« Sodelavci OpenStreetMap, 20. september 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.openstreetmap.org/relation/1685747>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Obstoječi zajem Overpass; © sodelavci OpenStreetMap, ODbL.

[47] »World report on social determinants of health equity,« WHO, 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240107588>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[48] »Prebivalstvo po starosti, občine, Slovenija, polletno,« Statistični urad Republike Slovenije, 18. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4003S.px>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Poizvedba: Slovenija in Črnomelj, H1 2008–2026, oba spola skupaj. Podrobni izvoz ob poročilu.

[49] »Prebivalstvo — izbrani kazalniki, občine, Slovenija, polletno,« Statistični urad Republike Slovenije, 18. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4008S.px>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Poizvedba: Slovenija in Črnomelj, H1 2008–2026, oba spola skupaj. Podrobni izvoz ob poročilu.

[50] »Prebivalstvo — izbrani kazalniki: metodološka pojasnila,« Statistični urad Republike Slovenije, 18. maj 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/05C4008S.px>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Poizvedba: Slovenija in Črnomelj, H1 2008–2026, oba spola skupaj. Podrobni izvoz ob poročilu.

[51] »Center za krepitev zdravja Črnomelj,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/ckz/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[52] »Dogodki in aktivnosti CKZ Črnomelj,« ZD Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/ckz/dogodki/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[53] »Urniki delavnic: april in maj 2025,« ZD Črnomelj, 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://zd-crnomelj.si/zvc/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/Urniki-delavnic-APRIL-IN-MAJ-2025-5.pdf>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[54] »Izobraževanje o najpomembnejši vrednoti,« Radio Odeon, 2022-04-09. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/izobrazevanje-o-najpomembnejši-vrednoti/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[55] »Festival zdravja v Radencih ob Kolpi,« Radio Odeon, 2025-04-09. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/festival-zdravja-v-radencih-ob-kolpi/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[56] »Naravoslovni dan na temo zdravja v PŠ Adlešiči,« Radio Odeon, 2024-03-04. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/naravoslovni-dan-zdravje-na-ps-adlesici/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[57] »Zdravstvenovzgojni centri / Centri za krepitev zdravja (ZVCT),« NIJZ, 14. april 2023, posodobljeno 7. april 2025. [Na spletu]. Dostopno: <https://nijz.si/podatki/podatkovne-zbirke-in-raziskave/zdravstvenovzgojni-centri-centri-za-krepitev-zdravja-zvct/>. [Dostopano: 22. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Prebrano osrednje besedilo spletne strani. Metodološke priponke niso pregledane. Vir ne potrjuje lokalnega spremljanja izidov; anketni list je avtorski predlog.

[58] »Povezani za zdravje: zbirnik informacij za krepitev zdravja v lokalni skupnosti,« ZD Črnomelj, CKZ, september 2025. [Na spletu]. Dostopno: https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2025/10/zbirnik-informacij-CKZ-crnomelj_cistopis.pdf. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Izdaja september 2025; natisnjene str. 31, 33–34 in 39–40, kar ustreza stranem PDF 33, 35–36 in 41–42 (šteto od 1). Kontakti iz imenika zahtevajo preverbo aktualnosti.

[59] »Otvoritev Centra za krepitev zdravja Bela krajina,« Radio Odeon, 2020-09-08. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/otvoritev-centra-za-krepitev-zdravja-bela-krajina/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[60] »Letošnji festival zdravja uspešno zaključen,« Radio Odeon, 2024-04-12. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/letosnji-festival-zdravja-je-zaključen/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[61] »Rožnati koraki v Dobličah,« Radio Odeon, 2024-10-15. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/roznati-koraki-v-doblicah/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[62] »Zobkovadba na OŠ Milke Šobar - Nataše,« Radio Odeon, 2025-03-25. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/zobkovadba-na-os-milke-sobar-natase/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[63] »Vitaminski dan,« Radio Odeon, 2025-05-14. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/vitaminski-dan/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[64] »Brkati pohod ozaveščal o zdravju moških,« Radio Odeon, 2025-11-25. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/brkati-pohod-ozavesca-o-zdravju-moskih/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[65] »Dan za zdrav nasmeh in dobre navade,« Radio Odeon, 2026-03-19. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.radio-odeon.com/novice/dan-za-zdrav-nasmeh-in-dobre-navade/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Sekundarni vir; dokaz o objavi oziroma opisu dejavnosti.

[66] »Črnomelj - Šola Zdravja,« Društvo Šola zdravja, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://solazdravja.com/obcina/crnomelj/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[67] »Črnomelj - Šola Zdravja,« Društvo Šola zdravja, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://solazdravja.com/skupina/crnomelj/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[68] »Kontakt – ZKDKS,« Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://zkdks.si/kontakt/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odprti shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[69] »Rehabilitacijska vadba koronarnih bolnikov odslej tudi v Črnomlju | Koronarno društvo DBK,« Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele krajine, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://koronarnodrustvo-dbk.si/rehabilitacijska-vadba-koronarnih-bolnikov-poslej-tudi-v-crnomlju/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[70] »Domov - Diabetiki Metlika,« Društvo diabetikov Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://diabetiki-metlika.org/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[71] »Kontakt - Diabetiki Metlika,« Društvo diabetikov Metlika, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://diabetiki-metlika.org/kontakt/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[72] »Skupina Bela krajina | Europa Donna Slovenija,« Europa Donna Slovenija, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://europadonna.si/skupnost-europa-donna/skupine/podruznica-bela-krajina/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[73] »Srečanja — Metuljčica,« Društvo Metuljčica, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.metuljcica.si/srecanja/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Uporabljen spletni izveček; neposredni prenos vrne 403.

[74] »Klubi,« Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.zdruzenjecvb.com/klubi.html>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[75] »Skupaj za duševno zdravje - Knjižnica Črnomelj,« Knjižnica Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://knjiznica-crnomelj.si/zgodilo-se-je/skupaj-za-dusevno-zdravje/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[76] »Hiša sadeži družbe Črnomelj – Slovenska filantropija,« Slovenska filantropija, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-crnomelj/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[77] »Dolenjska - Združenje multiple skleroze Slovenije,« Združenje multiple skleroze Slovenije, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.zdruzenje-ms.si/podruznice/dolenjska/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[78] »Demenci prijazne točke | Spominčica,« Spominčica – Alzheimer Slovenija, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.spomincica.si/demenci-prijazne-tocke/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[79] »Demenci prijazna točka (DPT) - Ljudska univerza Črnomelj,« Ljudska univerza Črnomelj, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.zik-crnomelj.eu/en/projekti/demenci-prijazna-tocka-dpt/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[80] »KONTAKTI – Hospic,« Slovensko društvo Hospic, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://hospic.si/kontakti/>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[81] »Seznam območnih odborov s kontakti,« Slovensko društvo Hospic, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://hospic.si/wp-content/uploads/2023/01/Seznam-vseh-obmocnih-odborov-s-kontakti.pdf>. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[82] »Šent - Dnevni center ŠENT Novo mesto,« ŠENT, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: https://www.sent.si/index.php?m_id=dnevni_center_enota_sent_novo_mesto. [Dostopano: 20. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Preverjena spletna navedba; kontakt ni telefonsko potrjen.

[83] »Popravek javne dostopnosti AED v občini Črnomelj,« Naročnik poročila, neposredno sporočilo, 23. september 2026. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Vsebinski popravek naročnika; neodvisna terenska preverba ni opravljena. Navedba ne določa dostopa 24/7 ali servisnega stanja.

[84] P. Jurić, G. Jurak, S. A. Morrison, G. Starc in M. Sorić, »Effectiveness of a population-scaled, school-based physical activity intervention for the prevention of childhood obesity,« Obesity, zv. 31, št. 3, str. 811–822, 2023. doi: 10.1002/oby.23695. [Na spletu]. Dostopno: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36811242/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[85] K. D. Hall in sod., »Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake,« Cell Metabolism, zv. 30, št. 1, str. 67–77.e3, 2019. doi: 10.1016/j.cmet.2019.05.008. [Na spletu]. Dostopno: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31105044/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[86] W. C. Knowler in sod., »Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin,« New England Journal of Medicine, zv. 346, št. 6, str. 393–403, 2002. doi: 10.1056/NEJMoa012512. [Na spletu]. Dostopno: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11832527/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[87] SPRINT Research Group, »A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control,« New England Journal of Medicine, zv. 373, št. 22, str. 2103–2116, 2015. doi: 10.1056/NEJMoa1511939. [Na spletu]. Dostopno: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26551272/>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo. Prebran strukturirani povzetek izvirne raziskave; ne celotno besedilo.

[88] »The SAFER initiative,« WHO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.who.int/initiatives/SAFER>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[89] »WHO clinical treatment guideline for tobacco cessation in adults,« WHO, 2024. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096431>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[90] »LIVE LIFE Initiative for Suicide Prevention,« WHO, b.d.. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.who.int/initiatives/live-life-initiative-for-suicide-prevention>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[91] »Accelerating childhood overweight reduction: lessons learned and the path towards 2030,« WHO, 2024-11-21. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/11/21/default-calendar/accelerating-childhood-overweight-reduction-lessons-learned-and-the-path-towards-2030>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[92] »Accelerating childhood overweight reduction: lessons learned and the path towards 2030 — prosojnice,« WHO, 2024-11-21. [Na spletu]. Dostopno: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/nutrition-and-food-safety/events/2024/webinar---accelerating-childhood-overweight-reduction---lessons-learned-and-the-path-towards-2030-presentation.pdf?sfvrsn=a331db34_5. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[93] »Launch of the WHO guideline on policies and interventions to create healthy school food environments,« WHO, 2026-01-27. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.who.int/news-room/events/detail/2026/01/27/default-calendar/launch-of-the-who-guideline-on-policies-and-interventions-to-create-healthy-school-food-environments>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

[94] »Policies and interventions to create healthy school food environments: WHO guideline,« WHO, 2026. [Na spletu]. Dostopno: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240118324>. [Dostopano: 19. september 2026]. Lokalni vir: odpri shranjeno gradivo.

Neodvisni raziskovalni pregled · osnova 19. 9. 2026, kader in šport 21. 9. 2026, obrazci CKZ 22. 9. 2026 · Pripravljeno s pomočjo jezikovnega modela in preverjanjem navedenih virov. Predlogi ukrepov niso že sprejete odločitve.